

10

2022. October

더 행복한 건강 생활

#운동과 건강

노화의 그림자,
근감소증

#건강검진 정보

답답한 속사정
'복무 팽만감'

#피플 포커스

국립암센터
서홍관 원장 인터뷰



위험에
대비하는
마음



글 이윤성
(서울대학교 명예교수, 법의학)

보험은 예기치 않은 사고로 입은 경제적 부담을 덜어주기 위한 제도다. 위험 자체를 피할 수는 없지만 위험에 대한 근심을 덜어주고 안심을 구입하는 것이다. 보험이 맡아주는 위험의 대상은 생명이나 건강의 훼손일 수도 있고, 재화의 손실일 수도 있다.

보험은 갈수록 더 다양하고 세밀해진다. 생명보험은 사람이 사망하면 사망 보험금을 지급하는데, 재해사망 특약에 가입하면 재해로 사망했을 때 사망보험금이 훨씬 많아진다. 질병으로 사망하면 일반 사망이고, ‘급격하고 우연한 외래의 사고’로 사망하면 재해 사망으로 구분한다. 치명적인 질병일지라도 일정 기간 투병하면서 사망에 대한 준비를 할 수 있지만, 사고로 갑자기 사망하면 졸지에 어려움을 겪게 되니, 재해 사망이 발생률은 낮지만 더 큰 위험이라고 보는 것이다.

급격하고 우연하다는 점에서는 같지만, 급성심근경색증이나 뇌동맥류파열 같은 질병으로 급사하면 재해 사망으로 판정하지 않는다. 여기에 대해선 보험 분쟁이 꽤 많이 발생한다. 예를 들어 한 여름철에 밭에서 일하던 노인이 숨졌을 때 열사병이면 재해 사망이고, 지병인 심장 질환으로 사망했으면 일반 사망이다. 지붕 공사를 하다가 뇌전증 발작으로 추락하여 사망하였으면 재해, 공중목욕탕 욕조 안에서 뇌전증 발작으로 익사하였으면 일반 사망이다.

손상을 입고 오랜 투병 끝에 사망하였다면 문제가 더 복잡해진다. 원칙은 이렇다. 손상 자체, 또는 손상의 직접적인 합병증(complication)으로 사망하였다면 재해지만, 손상의 후유증(sequela)으로 사망하였다면 사고와 사망 사이의 인과관계가 끊어졌다고 본다.

‘광견병은 재해사, 뇌염은 병사’라는 말이 있다. 광견병은 미친개(狂犬)에 물려 침 속에 있던 바이러스에 감염되는 병으로 치사율이 꽤 높은 감염 질환이고, 일본뇌염은 모기에 물려 일본뇌염 바이러스에 감염되는 병이다. 둘 다 바이러스 감염 질환이며 예방 백신이 있고, 특별한 치료제가 없어 증상과 징후에 따라 치료한다. 의학적으로는 그렇지만, 보험 실무에서는 차이가 크다. 작은소참진드기에 물려 생기는 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)도 보험 분쟁의 여지가 있다.

어제 점심 때, 가까운 한강공원에 산책을 다녀왔다. 막 집을 나가려는데 빗방울 몇 개를 맞았다. 비가 온다는 예보는 있었지만 정확하게 언제 얼마나 올지는 알 수 없었다. 우산을 가지고 갈지, 아니면 그냥 갈지 잠시 망설이다가 다시 들어가 우산을 가지고 나왔다. 산책하는 동안 몇 방울 더 맞았지만 우산을 피지는 않았다. 괜히 우산을 들고 나왔나 생각하기도 했지만 해지할까 고민하던 생명보험, 그대로 두기로 했다.



contents
2022 October

월간 <더 행복한 건강생활>
2022 October

등록번호 성북, 라00082
발행처 대한보건협회 후원 (재)서울의과학연구소
주소 서울시 성북구 보문로 121, 3F
전화 02-921-9520~1 / 팩스 02-921-2035
홈페이지 www.kpha.co.kr
발행인 전병을
편집위원장 오재석
편집위원 김연수, 박기수, 전상일, 조하연, 오한진
기획·총괄 정례현, 방형애, 유제영
편집·디자인 ㈜샘터사 02-763-8961

<더 행복한 건강생활>의 모든 저작물은 저작권법의 보호를 받아 무단 전재가 금지되며, 게재된 글은 필자 개인의 의견으로 대한보건협회의 공식 입장이 아님을 밝힙니다.

명사의 한마디 위험에 대비하는 마음	
02	이달의 테마 ‘주관적 건강상태 통계’ OECD 최하위?
04	운동과 건강 노화의 그림자, 근감소증
08	영양과 건강 노년기 근육관리를 돕는 ‘속 편한’ 단백질 섭취
10	건강검진 정보 답답한 속사정 ‘복부 팽만감’
12	전문의 칼럼 코로나19 팬데믹 시대, WHO의 역할
14	피플 포커스 서흥관 국립암센터원장 인터뷰 “항암신약과 신기술, 이제 자체 실력으로 개발해야”
18	보건진로 선택 101 4차 산업혁명 시대의 선봉장, 의료기기
20	인체의 신비 수술 장갑의 탄생
22	반려동물과 건강 반려견의 가을철 건강관리
24	해외 리포트 ‘다른 듯 닮은’ 일본의 코로나19 대응
26	감염병과 인문학 감염병보다 더 무서운 마음의 질병
28	마음을 치유하는 미술 존 컨스터블의 <건초마차>
29	메디톤 골다공증 예방
30	통계로 보는 건강 ‘혈관건강의 바로미터’ 혈당, 혈압, 콜레스테롤 수치
32	협회소식
뒤표지	건강 칼럼 가을의 의미

‘주관적 건강상태 통계’ OECD 최하위?

글 이윤현(한국보건사회학회장, 남서울대학교 보건행정학과 교수)

우리 국민들이 자신의 건강상태에 대하여 매우 부정적인 인식을 갖고 있는 것으로 밝혀져 우려를 낳고 있다. 2018년 기준으로 ‘나는 건강하지 않다’고 생각하는 비율이 68%나 된다. 기대수명은 OECD국가의 상위권에 있으면서도 자신의 건강에 대한 평가는 지난 10년간 변함없이 40%대 최하위로 부정적이였다.

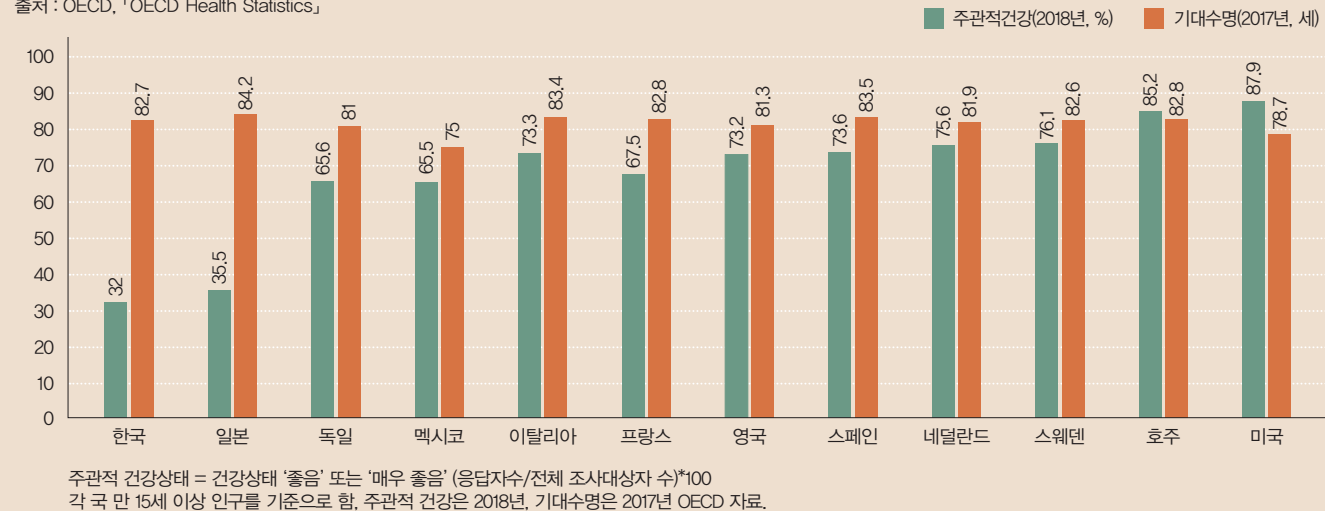
미국의 경우에는 기대여명이 우리나라보다 낮음에도 불구하고 주관적인 건강상태가 양호하다고 생각하는 비율이 87.9%에 이르러 우리나라의 3배에 달한다(그림1).

왜 이러한 결과가 나왔을까?

매년 발표되는 ‘주관적 건강상태’에 대한 조사결과는 OECD, WHO 등 국제기구 제출통계로 국가 간 건강상태 비교에 매우 중요한 자료로 활용된다. 일반적으로 주관적 건강(self-rated health)이란 사람들이 스스로 인지하고 주관적으로 평가한 건강 상태로 정의한다. 사람들이 질병 유무만으로 건강을 판단하지 않으며, 일상생활과 사회적 역할을 수행할 수 있는 신체적, 정신적 능력 또는 에너지 같은 부분까지 포괄적으로 건강을 이해하고

〈그림1〉 OECD 주요국의 주관적 건강 수준과 기대수명 비교

출처 : OECD, 「OECD Health Statistics」



측정하는 것이다.

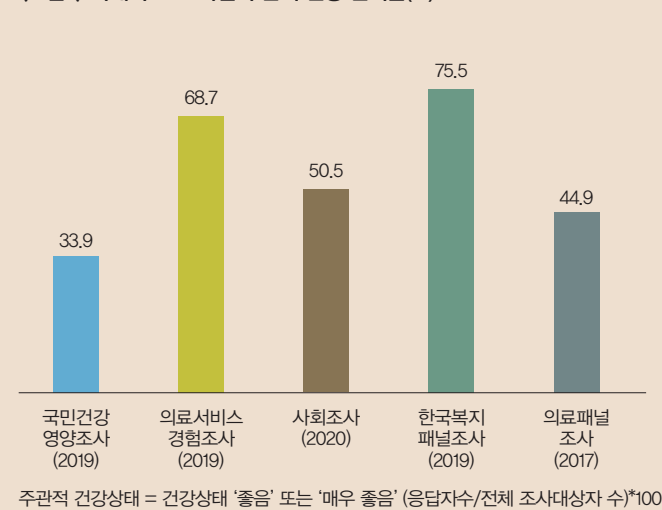
주관적 건강은 사람의 건강 상태를 포괄적으로 보여주 기 때문에 보건·의료적 차원은 물론 사회적으로도 유용하게 활용할 수 있는 지표이다. 국제적으로 건강수준을 비교할 때 자주 사용되는 이 지표로 보면, 우리나라는 경제대국이자 보건의료체계가 잘 갖추어진 국가임에도 불구하고 우리 국민의 건강상태는 OECD 최하위권으로 나타났다. 다만 국민건강영양조사 결과에서 나타난 주관적 건강 수치가 실제로 낮은 것인지 아니면 측정의 오류나 어떤 원인에 의하여 왜곡된 것인지는 분명하지 않다.

국내 주관적 건강상태 조사의 문제

우리나라는 5개 기관에서 주관적 건강상태에 대한 조사를 하고 있다. 국제기구에 보고하는 국민건강영양조사를 제외한 다른 사회조사에서는 상당히 양호한 수준의 주관적 건강이 측정되기도 한다(그림2).

이렇게 국내 조사별로 많은 편차를 보이는 이유는 무엇일까? 조사과정을 분석해보면 각각의 조사에서 몇 가지 중요한 차이를 발견할 수 있다. 첫 번째로 조사의 시점에 관한 부분이다. 국민건강영양조사는 주관적 건강의 설문 조사가 간단한 신체계측 후 건강검진을 앞두고 실시되고 있다. 이 경우에는 자신이 느끼는 건강에 비해 객관적 검진결과에 대한 불안으로 건강이 좋지 못하다고 보고할 가능성이 있다고 판단된다.

〈그림2〉 국내 주요 조사별 주관적 건강 인지율(%)



두 번째는 설문의 워딩에 대한 부분이다. 국민건강영양조사의 응답척도는 ‘매우 좋음- 좋음- 보통- 나쁨- 매우 나쁨’으로 좋음과 나쁨을 단정 짓는 척도 워딩을 사용하고 있다. 한 연구에서는 주관적 건강 척도에서 ‘보통’의 의미는 ‘ 좋음’ 쪽에 가까운 것으로 밝혀져 보통을 중립적인 표현(좋지도 나쁘지도 않다)으로 사용하거나 척도 용어를 수정하는 것을 고려해야 한다. 그리고 국가별로 응답범주 등 조사특성의 차이를 고려하지 않고, 단순 비교할 경우 비교 편향을 유발할 수 있으니 이를 주의하여 해석해야 한다.

세 번째는 조사방식이다. 국민건강영양조사, 의료서비스 경험조사, 사회조사는 대부분 면접 조사를 원칙으로 하고 있으나 상황에 따라 자가기입 방식으로 진행되기도 한다. 이에 따라 조사환경과 조사방식에 따른 차이가 발생할 수 있다. 더구나 국민건강영양조사의 경우 조사상황에서도 의료서비스경험조사, 사회조사와 달리 이동검진차량 내에서 건강검진과 함께 설문 조사를 수행하고 있다.

주관적 건강상태 국제기구 제출통계의 개선

결론적으로 국제기구에 제출하는 통계조사에 대한 개선이 분명히 필요하다고 말할 수 있다. 현행대로 국민건강영양조사에서 주관적 건강 문항을 제출할 경우, 조사세팅과정에서 건강검진과 설문을 동시에 진행하기보다 검진 이전에 방문 설문을 진행하여 검진으로 인한 편향이 생기지 않도록 개선할 필요가 있다.

또한 주관적 건강 상태 문항의 척도 중 ‘ 좋음’을 ‘ 좋은 편이다’, ‘ 나쁨’을 ‘ 나쁜 편이다’로 개선하는 것이 ‘ 보통’과의 거리를 넓혀 응답의 타당도를 높일 수 있다. 또 다른 방법으로는 국민건강영양조사의 주관적 건강상태에 대한 조사를 중지하고, 의료서비스경험조사와 같은 타기관 조사로 대체하는 방안도 있다.

현행과 달리 긍정적인 방향으로 바뀌기 위해서는 이보다 더 다양한 개선책을 강구해야 할 것이다. 이참에 정부는 국제기구에 보고하는 각종 국가통계에 대한 중장기적인 계획과 비전을 수립하여 국가통계를 보다 체계적이고 과학적으로 생산하는 기반을 조성하길 바란다.

노화의 그림자, 근감소증

우리는 건강이 행복을 좌우하는 백세시대에 살고 있다. 이제는 단순히 오래 사는 것보다 건강하게 오래 사는 것이 더욱 중요하다. 인구의 노령화가 점점 가속화되면서 노화와 관련된 다양한 질환들이 거론되고, 그 중 ‘근감소증(sarcopenia)’에 관심이 집중되고 있다. 근육을 단지 젊은 층의 전유물로만 생각하고 그 중요성에 대하여 간과하는 사람들이 많기 때문이다. 병명으로는 낯설기도 한 이 질환은 무엇이며 예방 및 관리는 어떻게 해야 할까?

글 서울대학교 스포츠의학 연구실

65세 김모 씨는 요즘 기력이 예전만 못하다고 느낀다. 몸무게는 그대로인데 허벅지는 언젠가부터 근육량이 줄면서 가늘어졌다. 발걸음은 무겁고, 걷는 속도도 느려져 좋아하는 자전거 타기와 등산을 중단한 지 오래다.

혼자서는 자유롭게 거동하기 어려운 순간도 가끔 찾아온다. 김 씨는 나이가 들었으니 근육량이 줄어드는 것도 당연하다 싶다가도, 같은 연령대에 많은 활동량을 소화하는 사람들을 보며 병원을 찾기로 결심했다. 병원에서 진료를 받은 김 씨는 ‘근감소증’을 진단받았다.

근감소증은 무엇일까? 근감소증의 어원을 살펴보면 근육(sarco)이 부족(penia)하다는 뜻을 가진 용어로, 몸을 구성하는 근육의 양과 힘, 기능이 정상보다 낮은 상태를 칭한다. 골다공증 및 관절염과 같은 노인질환은 우리에게 익숙하지만, 근감소증은 다소 생소하여 노화의 한

과정을 의미하는 것인지 아니면 질병들 중 하나인 것인지 헷갈릴 수 있다.

그러나 근감소증은 미국의 질병통제예방센터(CDC) 및 세계보건기구(WHO)에서 공식적으로 인정한 질병일 뿐만 아니라, 우리나라에서도 2021년 한국표준질병사인분류(KCD) 정식적인 진단코드가 부여된 엄연한 질환이다. 통계마다 차이가 있으나 근감소증 진단을 받은 환자는 65세 이상을 기준으로 하였을 때, 10명 중 1명 정도로 보고되고 있다.

근감소증, 어떻게 진단하나?

근감소증의 원인은 개인마다 다르나 주요 원인으로는 노화, 영양 상태의 불균형 및 부족, 신체활동량의 감소 등이 거론된다. 급성 및 만성질환, 퇴행성 질환의 발병 이후 이차적으로 발생하는 경우 또한 많은 것으로 알려져 있다. 근감소증이 발생하게 되면 근육의 기능이 저하되면서 낙상 및 부상의 위험이 높아지게 되고, 치매의 발병 위험 또한 높아진다.

또한 기초대사량이 낮아져 지방이 축적되기 용이한 상태로 몸이 변화되면서 쉽게 비만해질 수가 있는데, 근감소증에 비만까지 동반되었을 시 각종 만성질환의 주범인 대사증후군 발병 위험이 더욱 높아진 것으로 나타났다. 게다가 암, 당뇨, 심혈관질환을 갖고 있는 노인들 중 근감소증이 동반된 경우 그렇지 않은 노인들에 비하여 훨씬 높은 사망위험을 보였다고 보고되기 때문에 더욱 주의가 필요하다.

이 글을 읽는 독자는 ‘요즘 들어 기운이 없고 근육이 많이 줄어든 것 같은데… 혹시 나도?’ 하는 생각이 들 수

있다. 하지만 단순히 근육량이 적다고 해서 근감소증이라고 진단하지는 않는다. 일반적인 기력 저하와도 다르다. 그렇다면 근감소증은 어떤 기준으로 진단되는 것일까? 보행 속도가 초당 0.8m 이하인 경우, 악력 측정값이 남성 26kg 이하 · 여성 18kg 이하인 경우, 의자에서 다섯 번 앉았다 일어나며 소요되는 시간이 15초 이상 되는 경우 근감소증을 의심하여 보다 정확한 검사를 진행한다.

하지만 관련 기관을 방문하지 않는 한 일상에서는 정확하게 측정하기 어려운 지표들이기 때문에 근감소증의 존재 여부를 알아내기가 쉽지 않은 실정이다. 이러한 검사들을 거치지 않고도 간단한 설문문을 통해 근감소증 의심 여부를 알아볼 수 있는 ‘근감소증 자가진단설문지(SARC-F)’가 있으니 참고해 보자. (표1)

해당 설문은 근력, 보행보조, 의자에서 일어서기, 계단 오르기, 낙상과 관련한 다섯 가지의 항목으로 이루어져 있고, 질문별로 수행이 가능한 수준에 따라 점수를 매겨 점수의 총합이 10점 만점 중 4점 이상이면 근감소증이 의심되는 것으로 분류한다.

운동과 영양 관리 병행하여 근육 지켜내기!

근감소증은 어떻게 치료할 수 있을까? 근감소증은 아직 치료제가 존재하지 않는데, 그만큼 예방 및 관리가 중요한 질환이다. 근감소증 개선에 가장 효과가 있다고 전문가들이 한목소리로 강조하는 것은 두 가지이다.

첫 번째는 운동이다. 운동의 여러 종류 중에서 근력운동이 근감소증의 개선에 가장 효과적이라는 연구 결과가 지속적으로 나오고 있다. 노인이라도 근력운동을 꾸준히 시행하면, 근력 및 근육량이 증가해 혈류 개선의 효과를

표1. 근감소증 자가진단설문지(SARC-F)

구분	질문	점수		
근력	무게 4.5kg을 들어서 나르는 것이 어려운가요?	0 전혀 어렵지 않다	1 좀 어렵다	2 매우 어렵다
보행보조	방안 한쪽 끝에서 다른 끝까지 걷는 것이 어려운가요?	0 전혀 어렵지 않다	1 좀 어렵다	2 매우 어렵다
의자에서 일어나기	의자(휠체어)에서 일어나 침대(잠자리)까지 이동하는 것이 어려운가요?	0 전혀 어렵지 않다	1 좀 어렵다	2 매우 어렵다
계단오르기	10개의 계단을 쉬지 않고 오르는 것이 어려운가요?	0 전혀 어렵지 않다	1 좀 어렵다	2 매우 어렵다
낙상	지난 1년 동안 몇 번이나 넘어지셨나요?	0 없다	11~3회	4회 이상

기대할 수 있다.

두 번째는 영양이다. 근육에 가장 중요한 영양 요소는 단백질이며, 충분한 양의 단백질 섭취는 근감소증 치료 및 관리에 있어 필수적이다. 필수 아미노산 중심의 단백질을 권고수준으로 섭취하여야 한다. 영양은 근감소증의 치료 및 관리에 있어 운동만큼 중요한 요소이지만, 운동이 없는 영양 관리는 그 효과가 명확하지 않다. 근력 운동과 적절한 영양 섭취가 병행되었을 때, 근감소증의 상태가 유의미하게 호전되었다고 보고되었다.

근감소증 예방 및 관리를 위한 근력운동의 방법 및 영양섭취 기준을 알아보자. 근력운동의 방법은 보행에 필수적이며 인체에서 근육이 가장 많이 분포되어 있는 하체의 큰 근육들을 단련하는 데에 신경쓰는 것이 좋다. 엉덩이, 허벅지, 종아리 근육 등 하체 위주의 근력운동을 위주로 하는 것을 권장한다. 피트니스 센터에 가지 않더라도 운동 소도구를 이용하여 일상 속에서 할 수 있는 간단한 근력운동을 소개한다.

◆ 물병 런지 (bottle lunge)

▷ 허리를 곧게 펴서 물병을 양손에 들고 앞뒤 무릎의 각도가 약 90도가 되도록 앉는다. 무릎이 발끝보다 앞으로 나오지 않도록 하며, 뒷발의 무릎은 지면에서 살짝 떨어지도록 유지한다.

▷ 균형잡기가 힘들 경우, 양 발의 보폭을 더 넓게 벌려 실시하는 것이 좋다.

◆ 엎드려서 다리 뒤로 들어올리기 (prone back leg kick)

▷ 바닥에 엎드려 네발기기 자세를 취한다.

▷ 한쪽 다리를 뒤로 들어서 올린다. 이때, 골반이 틀



어지지 않도록 한다.

▷ 지지하는 무릎 쪽에 부담이 갈 경우, 수건을 무릎 아래에 받쳐서 실시해 본다.

◆ 밴드 잡고 누워서 다리 밀기 (band supine leg press)

▷ 바닥에 누워 밴드를 양손으로 잡아 발바닥에 고정시킨 후, 무릎을 약 90도로 굽힌다. 무릎을 몸 쪽으로 당길 때, 무릎이 벌어지지 않도록 한다.

▷ 무릎을 펴면서 다리를 위로 밀어 올린다. 이때, 무릎은 완전히 펴지 않고 약간 굽힌 상태를 유지한다.

근력운동은 과하지 않게, 꾸준히!

운동을 하는 것만큼 중요한 것은 운동하면서 다치지 않는 것이다. 고령자는 자신의 상태를 고려하지 않고 과한 운동을 하게 되면 근골격계의 부상으로 이어질 수 있다. 권고되는 운동은 질병의 유무 및 경중별로 상이할 수 있으므로 전문가와 상의하여 운동 처방 및 지도를 받는 것이 안전하다.

예를 들어 골관절염 등으로 무릎이 아플 경우 무릎을 과하게 굽히는 등 무릎에 심한 부하가 가해질 수 있는 운동 동작들은 피하는 것이 좋다. 이 경우에는 근육에 힘을 주면서도 근육의 길이와 관절의 각도는 그대로 유지되는 등척성 운동(isometric exercise)을 권장한다. 의자에 앉아 한쪽 다리를 편 후 떨어지지 않게 버티는 동작, 누운 자세에서 양 무릎 사이에 베개를 끼워 떨어뜨리지 않게 힘을 주어 유지하는 동작 등을 예로 들 수 있다. 또한, 운동 중 현기증이 나거나 가슴이 조이는 느낌이 드는 경우, 불규칙한 심장박동이 느껴질 때에는 즉시 운동을 멈추고 전문가의 진료를 받아보아야 한다.

영양을 고려하여 단백질도 섭취해야 하지만, 적절량을 참고하는 것이 좋다. 국민건강영양조사를 통하여 권고되는 일일 단백질 섭취량은 체중 1kg당 약 1g 이상이다. 이는 65kg의 성인이라면 하루 65g 이상의 단백질을 보충하여



근력운동의 방법은 보행에 필수적이며 인체에서 근육이 가장 많이 분포되어 있는 하체의 큰 근육들을 단련하는 데에 신경쓰는 것이 좋다.

엉덩이, 허벅지, 종아리 근육 등 하체 위주의 근력운동을 위주로 하는 것을 권장한다.

야 한다는 뜻이다. 이에 비해 근감소증 환자나 근감소증 예방이 필요한 고령자에게 제시하는 권장량은 체중 1kg당 약 1.2g인데, 이는 건강한 일반 성인보다 더 많은 양의 단백질을 섭취하여야 근육을 유지 및 개선할 수 있기 때문이다.

생선, 두부, 계란, 콩 등 양질의 단백질 공급원 섭취를 권장하며, 동물성 단백질과 식물성 단백질을 골고루 섭취하는 것이 바람직하다. 식품만으로 단백질 권장량을 모두 채우기 어려울 경우에는 단백질 보충제를 이용할 수 있다.

노년층에게 근육은 생존을 위한 필수 요소이며, 건강한 노후를 위해서는 근육의 감소를 최소화하여야 한다. 노화로 인한 근감소증을 막을 수 없지만 그 속도는 늦출 수 있다. 꾸준한 운동으로 근육을 잘 가꾸고, 균형 잡힌 식단으로 영양 상태를 관리하여 건강하고 생기 있는 노년을 맞이하자.



이 QR코드를 스캔하면 국민체육공단에서 제공하는 '근력운동 3가지 운동법' 동영상으로 연결됩니다.
출처: KSPO 국민체력 100



노년기 근육관리를 돕는 ‘속 편한’ 단백질 섭취

글 전해연(마크로비오틱 비건식탁 오늘 대표)

몇 달 전 오스카 시상상을 위해 미국을 찾은 배우 윤여정의 미국 체류기를 담은 예능 프로그램이 인기를 끌었다. 나이를 의식하지 않는 수평적인 태도와 동료들 살뜰히 챙기는 배려 넘치는 모습이 방송을 타며 수많은 시청자들이 또 다시 윤여정의 매력에 푹 빠져들었다.

그 중에서도 70대 중반의 그녀가 매일 스쿼트와 푸쉬업을 거르지 않는 장면은 특히 시선을 끌었다. 출장 중에도 기초근력운동을 빼놓지 않는 모습은 배우 윤여정의 철저한 자기관리를 엿볼 수 있게 했다. 하지만 윤여정처럼 자기관리를 철저히 해야 하는 직업이 아니어도 노년기의 근육관리는 모두에게 필수다. 나이가 많아지면 자연스럽게 근육의 양, 근 기능이 감소하는 근감소증을 경험하기 때문이다. 근육량이 줄어들면 일상생활을 유지하기도 어렵

고, 기타 질병을 악화시키기도 하니 주의해야 한다.

‘속 편하게’가 노년기 근육 관리 식단의 포인트

근감소증을 예방하기 위해서는 운동과 식단 두 마리 토끼를 모두 잡아야 한다. 근육관리 식단의 중요한 포인트는 근육의 원료가 되는 단백질이다. 단백질 함량이 가장 높은 식품군은 동물성 식품, 그 중에서도 육류이다.

동물성 단백질은 소화뿐만 아니라 대사도 쉽지 않은 영양소이다. 그리고 동물성 식품은 포화지방과 콜레스테롤을 함유하는 경우가 많기 때문에 과하게 섭취하면 다른 성인병에도 악영향을 끼칠 수 있다. 이 때문에 소화능력이 약하거나 성인병력이 있는 노인은 동물성 단백질 섭취에 주의를 기울여야 한다.

노년기 근육관리를 위해서는 속 편하게 단백질을 섭취하는 것이 중요하다. 속 편하게 단백질을 섭취할 수 있는 첫 번째 방법은 식물성 단백질 위주로 섭취하는 것이다. 육류와 해산물뿐만 아니라 식물성 식품을 통해서도 단백질을 섭취할 수 있다. 단백질 함량이 높은 식물성 식품으로는 콩이 대표적이며 견과류, 씨앗류, 브로콜리나 시금치와 같은 녹색 채소도 훌륭한 식물성 단백질원이다. 식물성 단백질은 동물성 단백질보다 소화가 편하고, 포화지방과 콜레스테롤 지수도 낮기 때문에 성인병이 있는 노인도 안심하고 섭취할 수 있다.

속 편하게 단백질을 섭취하는 두 번째 방법은 소화를 돕는 음식을 함께 섭취하는 것이다. 대표적인 음식은 무다. 특히 익히지 않았을 때의 무가 더욱 효과가 크다. 하지만 감미료를 듬뿍 넣은 무 피클, 무장아찌는 외려 단백질의 흡수를 방해하니 피하는 것이 좋다. 그 밖에도 표고버섯과 생강이 동물성 단백질 분해를 도우며, 레몬과 같은 시트러

스 계열의 과일은 기름진 음식의 소화를 돕는다.

하지만 무엇을 먹든 소화의 기본은 ‘꼭꼭 씹어먹기’임을 잊지 말아야 한다. 소화는 음식이 침 속의 소화 효소와 만나는 순간부터 시작된다. 이 때문에 침의 분비를 원활하게 하고, 음식물의 크기를 더 잘게 쪼갤 수 있게끔 충분히 씹는 습관을 들이면 소화기능이 약한 노인도 조금은 속 편하게 단백질을 섭취할 수 있다.

속 편하게 단백질을 섭취하고 싶은 노인에게 추천하는 음식은 ‘강청국장’이다. 강청국장은 청국장을 주재료로 만드는 되직한 국물 요리로 강된장처럼 밥에 비비거나 쌈을 싸먹는 음식이다. 콩 발효식품인 청국장과 단백질 함량이 높은 두부를 곁들여 으개서 만드는 만큼 소화가 잘되는 식물성 단백질 식품이다.

한국인에게 익숙한 재료로 만들기 때문에 외국 음식보다는 한국 음식을 선호하는 노인들도 거부감 없이 먹을 수 있는 고단백 식품이기도 하다.

강청국장 레시피



[재료] 3인분

청국장 150g, 불린 표고버섯 2개 (새끼손톱 반 정도의 크기로 다진다), 두부 반 모, 풋고추 2개 (굵게 다진다), 물 300~400ml, 소금 1~1.5작은술, 부추 소량

[만드는 과정]

1. 청국장에 물 약간을 더해 콩 입자를 으갠다. 곱게 으갠수록 비비기 쉽고 부드러운 강청국장으로 완성된다. 도구는 절구, 포크, 푸드프로세서 등을 사용하면 된다.
2. 두부를 손으로 잘게 풀어 깨끗한 천 위에 올려 물기를 빼둔다.
3. 냄비를 달궈 기름을 소량 두르고 표고버섯을 살짝 꼬들꼬들해질 정도로 볶는다.
4. 표고버섯이 꼬들꼬들해지면 표고버섯이 살짝 잠길 정도의 물을 붓고, 풋고추와 2의 두부를 넣고, 풋고추가 부드러워질 때까지 중약불에서 끓인다.
5. 풋고추가 부드럽게 익으면 으개놓은 청국장과 소량의 물을 넣고 뚜껑을 덮고 약불에서 가열한다. 청국장이 부드러워지고 수분이 줄어들 때까지 끓인다. 원하는 농도가 되면 소금으로 간을 하고 불에서 내린다.
6. 그릇에 담고 먹기 전 취향에 따라 부추를 다져 올린다.

답답한 속사정 ‘복부 팽만감’

글 성상엽(하나로의료재단 기능의학 R&D본부장)

누구나 한번쯤은 속이 더부룩하고 답답하며 불편한 컨디션을 경험한 적이 있을 것이다. 이런 불편함을 자주 경험한다면 이때는 꼭 그 속사정을 들여다봐야 한다. 왜냐하면 여기에는 반드시 해결해야 할 건강문제가 숨어있을 수 있기 때문이다.

복부 팽만감(Abdominal Bloating)은 다양한 종류의 기능성 위장질환에서 흔하게 나타나는 증상 가운데 하나이다. 복부 팽만감이란 실제 측정 가능한 복부 팽창(abdominal distention)과 관련 없이 반복적으로 복부가 팽창하는 듯한 느낌을 의미한다.

여러 요인에 의해 발생하는 복부 팽만감

팽만감의 병태생리는 아직 완전하게 이해되고 있지 않으며 여러 요인들이 복합적으로 작용한다. 팽만감은 공기 삼킴증(aerophagy), 폭음, 폭식, 위 혹은 장 막힘, 흡수장애(malabsorption), 위 혹은 장운동 저하, 복부 내 종(혹), 장내 세균 이상, 가스 차기, 장 통과 장애(음식과 장내에 저류되어 있는 액체 또는 대변), 복강 내 지방, 복부근육의 운동장애 등의 인자들이 팽만감을 초래할 수 있다.

또 신경성식욕부진, 대식증(bulimia) 혹은 정신적인 신체화 장애(내과적 원인 없이 신체적 이상을 반복적으로 호소하는 정신장애) 등으로 인하여 발생하기도 한다. 이러한 기질적, 정신적 원인 없이 팽만감이 발생할 땐 기능성 팽만감으로 생각할 수 있다.

팽만감이 최근 3개월 동안 최소 한 달에 3일 이상의 빈도로 나타나는 반복적인 팽만감, 또는 육안으로 확인되는 팽창이 있으면 우선 철저한 병력조사와 신체검사를 시행하여 원인을 뚜렷이 알 수 있는 질환(기질적 질환)을 배제해야 한다. 그리고 빈혈, 의도하지 않은 체중 감소 등 경고 증상이나 징후가 있는지 우선 점검한다.

또한 팽만감과 함께 다른 증상을 호소한다면 각각의 증상에 대한 검사를 시행하여야 한다. 소장촬영, 위배출능 검사, 분변 검사, 대장내시경 검사 등을 할 수 있으며, 무엇보다 중요한 점은 검사를 통하여 위장관 폐색(막힘)의 유무를 확인하는 것에 있다. 기질적 질환을

배제한 후에는 반드시 복부팽만을 줄이기 위한 식이생활 습관 교정이 필요하다.

복부팽만감 증상과 올바른 생활건강 수칙

아래 복부팽만에 관한 증상과 그에 따른 식이생활습관 교정 방법을 알아보고 실천해보자.

1. 속이 더부룩한 느낌, 장에 가스가 많이 찬다(방귀가 잦고 냄새가 지독).

- 음식을 천천히 많이 씹고, 껌, 탄산음료, 지나친 육식을 피하고 섬유질이 풍부한 제철 과일, 채소 등의 음식 섭취, 저포드맵(Low FODMAP) 식단 권장

※포드맵(FODMAP): 소장에서 잘 흡수되지 않아 과민성대장증후군(IBS)을 악화시키는 종류의 탄수화물(Fermentable Oligosaccharides Disaccharides Monosaccharides And Polyols).
예: 잡곡, 보리, 콩물, 유제품, 농축과일 주스, 양배추, 브로콜리, 탄산음료, 커피, 인공감미료 등

2. 과식(배가 부를 정도)을 하루 1번 이상 한다.

- 적은 양(적당히 배가 부르지 않을 정도의 양)으로 하루 3번 규칙적으로 식사
- 소화에 도움이 되는 과일(배, 키위, 파인애플, 무, 매실 등), 허브차(레몬밤, 페퍼민트)를 식후 적당히 섭취

3. 짠 음식 또는 기름진 음식(빵, 밀가루, 튀김, 기름진 육류 등), 단 음식(쿠키, 사탕, 초콜릿 등)을 선호한다.

- 소금, 장류, 인공조미료가 많이 들어있는 음식과 패스트푸드, 기호식품(음료, 과자, 조미 식품), 외식 절제

4. 적당한 양(2컵 정도)의 섬유소(과일, 채소, 잡곡, 콩류)가 있는 음식을 하루 1번을 초과해 섭취하지 않는다.

- 섬유질이 풍부한 제철 과일, 채소 등의 섬유질 식품을 적당량 섭취한다.

5. 변비 또는 변비성 배변 습관을 가지고 있다.

- 충분한 수분(하루 2리터 또는 500ml 물병 4개 또는 8컵 이상) 섭취, 최소 하루 30g(2~3컵) 섬유소를 섭취, 배변감이 있을 때 참지 않기.

6. 탄산음료와 커피, 술을 자주 마신다.

- 하루에 마시는 탄산음료와 커피의 양을 하향 조절하고, 음주는 자제한다.

7. 유제품(치즈, 우유, 요거트 등)에 예민하다.



- 우유, 유제품 섭취를 줄이고 소화가 잘 되도록 가공한 기능성우유(소화가 잘되는 우유, 유당 제거 우유) 권장, 섬유소가 풍부한 선식이나 두유, 또는 쌀우유로 대용한다.

8. 식사를 급하게 하며 많이 씹지 않는 편이다.

- 음식을 천천히, 여러 번 씹어 섭취한다.

9. 스트레스를 많이 받거나 불안 증상이 있다.

- 자신을 인정하고 긍정적인 사고를 하며 감정과 생각을 말로 표현(전문가 또는 멘토 상담 등), 요가, 스트레칭, 복식 호흡, 명상 등 규칙적인 취미생활 권장

10. 적당한 운동 또는 걷기를 하지 않는다(장시간, 3~4시간 앉아 있다).

- 1시간 좌정 시 10분 정도 휴식과 스트레칭 권장, 운동 애플리케이션 사용해 매일 걸음 수를 유지한다(하루 1만보 걷기 목표).

11. 최근 몸무게가 증가하여 허리둘레가 늘었거나 급격히 몸무게가 줄었다.

- 유산소 운동과 근력 운동(특히 복근 운동) 권장, 식사는 적은 양(저칼로리, 저지방, 저당 식단)을 규칙적으로 섭취한다.

12. 특정음식에 예민하게 반응한다.

- 식사일지(식사 시간, 섭취한 음식, 식사하는데 걸린 시간, 소화 불량 증상 등)를 일주일 주기로 써보며 어떤 음식에 반응하는지 확인한다(더부룩함이 2회 이상 나타나면 맞지 않는 음식). 맞지 않는 음식은 식단에서 제외한다.

* 대체로 예민한 음식: 우유, 유제품, 계란, 생선, 갑각류(새우, 조개, 랍스터, 게 등), 땅콩류, 대두, 밀가루, 미원 조미료(MSG), 카페인, 알콜, 인공감미료, 방부제, 색소 등



코로나19 팬데믹 시대, WHO의 역할

글 손명세(SCL 글로벌보건개발원장, 연세대학교 의과대학 명예교수)

코로나19로 인해 국제적 공중보건비상사태가 선포된 2020년 1월 30일 이후 현재까지 전 세계적으로 약 6억만 명이 확진되었고 약 651만 명이 사망하였다. 사회적 거리두기의 실천과 예방접종을 향상을 위한 노력에도 변이 바이러스의 출현과 오미크론의 확산으로 전 세계적으로 팬데믹이 지속 중이다.

그런 가운데 세계보건기구(World Health Organization, WHO)는 국가와 지역 및 글로벌 수준에서 팬데믹 문제 해결을 위한 국제보건의 리더로서 역할을 하고 있다. WHO의 국제보건규칙(International Health Regulation, IHR)은 중증 감염병 유행상황을 감시하고, 국가 간 전파를 방지하기 위해 채택한 규범이다.

회원국의 보건당국은 WHO에 신종감염병인 코로나19 발생 상황을 보고함으로써 국제사회가 해당 정보를 신속하게 공유하였다. 코로나19 대응에 있어 IHR은 ‘국제보건레짐’으로서 감염병 발생 당사국의 확인 및 정보 공유, WHO에 대한 국제사회의 정보 공유, 비상위원회 소집 및 공중보건비상사태의 선언, 여행 관련 권고 사항 및 공중보건 조치 발표, 국제사회의 협력 및 조정 등의 중요한 역할을 담당한다.

또한 WHO는 회원국의 IHR 이행 역량 평가를 위한 도구를 개발하여 적용함으로써 공중보건위험을 예방, 감지 및 신속하게 대응할 수 있는 국가의 능력 점검과 향상에 기여해왔다. 국제보건규칙 핵심역량 모니터링체계

(IHR Core Capacity Monitoring Framework)를 마련하였으며 국가들의 공중보건위기대응 핵심역량 모니터링 도구를 통해 당사국들의 준수 여부에 대한 각국의 공중보건위기대응 자가평가와 외부평가를 실시하고 있다.

코로나19에 연대하는 WHO의 활동

코로나19 발생 이후 필자를 포함, 국제적으로 21명의 전문위원으로 구성된 WHO의 국제보건규칙 기능심의 위원회가 2020년 9월 소집되어 2021년 4월까지 국제보건규칙 재개정을 논의하였다. 코로나19 대응에 있어 국제보건규칙 기능의 효용성 검토, 국가별 국제보건규칙 핵심역량의 이행상태 검토, 국제보건규칙 개정에 대한 권고사항 등을 제시하였다.

국제사회는 준국제법인 IHR을 법적 구속력이 강한 국제법인 조약으로 격상하여 감염병 등의 공중보건위험에 대한 예방, 대비, 관리 및 대응 체계를 강화하기 위한 협의를 진행 중으로 미래 팬데믹 대비·대응을 위한 새로운 규범을 마련하고자 팬데믹 조약(Pandemic treaty) 제정을 위한 정부 간 협상기구를 운영하고 있다.

또한 WHO는 코로나19 등 긴급한 보건위기 상황에서 백신 및 치료제를 신속하게 공급하기 위해 안전성, 유효성 및 품질 기준을 갖춘 의약품을 긴급사용목록(Emergency Use Listing, EUL)에 등재하고 있다. WHO PQ(Prequalification)는 WHO가 저개발국가에 대한 의약품 및 의료기기 공급을 위해 품질 및 안정성 유효성을 심사하여 인증하는 과정으로 사전적격심사에서 승인된 품목만이 WHO, UNICEF, UNITAID 등의 유엔기구와 GAVI, 글로벌펀드와 같은 국제 NGO의 국제입찰에 응찰할 수 있는 자격이 주어진다.

UN의 의약품 조달시장에 진출하기 위해서는 WHO의 PQ 인증을 받아야 하나 긴급 상황에는 WHO의 긴급사용목록(EUL)에 등재되면 간소화된 인증절차를 거쳐 의약품을 판매할 수 있도록 하였다. 에볼라 대응을 위해 의약품, 진단키트, 백신에 대한 긴급사용을 위한 평가 및 등재절차를 처음 시행하였으며 국제적 공중보건 비상사태 시 새로운 체외진단기기, 의약품, 백신의 품질과 안



정성을 긴급하게 검증하고 사용할 수 있도록 인증제도를 운영 중이다.

전세계 예방접종률 60% 달성의 성과에도 최근 감염 확산으로 백신을 접종하지 않은 사람들 사이에서 새로운 변이 위험이 커질 우려가 있어 코로나19 예방접종률을 높이는 것이 필요하다. WHO는 백신의 사전적격심사에서 국제표준을 적용하여 백신이 안전하고 효과적인지 종합적으로 평가하고 결정한다. 또한 정기적인 재평가, 현장 조사, 표적 테스트 및 예방 접종 후 제품 불만 또는 부작용에 대한 조사를 통해 사전 검증된 백신의 지속적인 안전성과 효능을 보장한다. WHO 백신 사전인증제도는 백신 개발의 혁신과 신제품에 대한 충족되지 않은 공중보건 수요 충족에 기여하고 건강한 백신 시장의 형성과 유지에 있어 역할을 한다.

COVID-19 대유행은 전 세계의 단합, 연대, 국가 간 협력을 기반으로 한 세계적 대응이 필요함을 새삼 일깨워주었다. 코로나19는 모든 곳에서 끝나기 전에는 그 어느 곳에서도 끝난 것이 아니며 연대의 정신으로 모두가 함께 할 때 성공할 수 있다. 코로나19로부터의 회복과 재건을 위해 통합적인 접근을 시도하는 WHO의 활동을 지지하며, 코로나19의 종식과 미래 감염병 대유행을 대비하기 위한 국제협력 강화에 힘을 보탬 수 있기를 기대한다.



서홍관 국립암센터원장 인터뷰

“항암신약과 신기술, 이제 자체 실력으로 개발해야”

대담 박기수(대한보건협회 홍보이사, 대변인) | 사진 이권호

서홍관 국립암센터원장(64)은 지난해 9월 국가암빅데이터센터 지정을 계기로 전 세계에서 가장 질 높은 빅데이터가 구축되면 국내 기반의 신약과 신기술 연구가 활성화될 것이라며 적극적인 투자를 촉구했다. 자타공인 금연운동의 대부이자 전도사인 서 원장은 “건배사처럼 남에게 발암물질을 권하는 행위는 잘못된 습관이고, 하루 빨리 금지해야 한다”며 암 예방을 위한 금주운동에도 매진하겠다는 의지를 피력했다. 서울대 의대 졸업 직후 창비를 통해 시인으로 등단한 서 원장은 “시는 특별한 깨달음의 결정체”라며 “좋은 의사가 되는 과정과 좋은 시를 쓰는 일이 다르지 않다”고 말했다.

개원 21주년을 맞은 국립암센터의 원장으로 재직하시면서 가장 역점을 두는 분야와 목표는 무엇입니까? 그리고 향후 비전을 듣고 싶습니다.

현재 우리 국민들의 사망원인 1위는 암입니다. 따라서 암을 해결하지 않고는 국민 건강을 지킬 수가 없습니다. 국립암센터는 ‘국민을 암으로부터 보호한다’는 사명을 가진 국립기관입니다. 국민을 암으로부터 보호하기 위해서 가장 중요한 일은 암 예방이고, 두 번째 필요한 일은 조기 검진이고, 세 번째 필요한 일이 암의 치료라고 생각합니다. 그리고 이 모든 과정에서 연구가 필요합니다.

사립의료기관들은 암 예방에 앞장설 책임이나 이유도 없습니다. 그런데 국립암센터도 그렇게 한다면 누가 암 예방에 앞장서겠습니까? 사립의료기관들이 하지 못하는 일이지만, 국민건강에 꼭 필요한 일을 하는 것이 우리 국립암센터가 해야 할 일입니다.

암 예방에서 가장 중요한 것은 건전한 생활습관입니다. WHO 산하 국제암연구소 자료에 따르면 암의 원인은 흡연 30%, 음식 30%, 만성감염 18%, 술 3.5%를 차지하고 있습니다. 흡연과 간접흡연을 피하고, 음식은 짠 음식과 탄 음식을 먹지 말아야 하며, 신선한 과일과 채소 섭취를 늘려야 합니다. 또한 적정체중을 유지하는 것도 중요하고, B형간염과 인유두종바이러스에 대한 백신접종도 필요합니다.

그에 비하면 우리 국민들의 경각심은 한참 못 미치고 있다는 생각이 듭니다.

안타까운 현실이지요. 암 예방에 있어서 가장 중요한 일은 금연이기 때문에 하루 빨리 금연 정책을 추진해야 합니다. 그밖에 우리나라 국민들이 가장 많이 섭취하는 1군 발암물질인 알코올에 대해서도 예방 대책이 필요합니다. 무려 2500만 명이 술을 마시는데, 이것이 발암물질이라는 것조차 모르고 있습니다. 일반 국민만 모르는 것이 아니라 의사들도 잘 모르고 있으니 더 큰 문제지요.

한때 소량의 음주는 심장질환예방에 도움이 된다고 하여 적정음주량이라는 개념이 있었고, 하루 두 잔까지는 괜찮다고 했는데, 지금은 다 바뀌었습니다. 실제로 생존

그래프를 그려보면, 한 잔도 마시지 않는 사람의 생존율이 가장 높습니다. 따라서 2015년 유럽의 암 예방수칙에서도 소량의 음주도 하지 않는 것이 좋다고 바뀌었습니다. 우리나라도 2016년 국민 암 예방수칙을 ‘하루 2잔 이내’는 괜찮다고 했던 항목을 ‘소량음주도 피하기’로 개정한 바 있습니다. 앞으로 금주운동을 통해 인식을 바꾸는 일을 할 예정입니다.

개인적으로는 술을 권하는 ‘건배문화 없애기’부터 하면 좋겠습니다. 예전에는 담배도 서로 권하는 ‘담배인심’이라는 것이 있었지만 지금 누가 담배를 남에게 권할 수 있겠습니까? 이제 건배사처럼 남에게 발암물질을 권하는 행위는 잘못된 관습이고 해서는 안 됩니다.

최근 암 발생과 사망률 추이에서 눈에 띄는 변화는 어떤 것이 있습니까? 또 이에 대한 정부의 대응은 어떤 건가요?

고령사회가 되고, 서구식 문화 · 식습관이 보편화되면서 이른바 ‘선진국형 암’이라 불리는 유방암, 전립선암, 대장암의 환자수가 증가해왔고, 반면 백신이 개발되어 있는 간암, 자궁경부암은 지속적으로 감소하고 있습니다. 지난 연말 발표한 2019년 국가암등록통계에 따르면, 우리나라에서 새로 진단받은 암 환자 가운데 갑상선암(신규 암환자 25만 명 중 12%)이 가장 많았습니다. 2009년부터 2014년까지 전체 암종 중 발생 1위를 차지했다가, 2014년 갑상선암 과다진단 논란 이후 감소하던 것이 다시 5년 만에 1위가 된 것입니다.

우리나라는 갑상선암이 발생률 1위인 유일한 국가입니다. 전 세계에서 무증상인 일반인들에게 갑상선암 검진을 권고하는 나라는 없는데, 무분별한 갑상선암 검진이 갑상선암의 폭발적인 증가로 이어진 것입니다.

미국 보건부에서 갑상선암 검진에 대해서 평가를 했는데, ‘해로움이 이득보다 크기 때문에 하지 말 것을 권고한다’는 D등급을 받았습니다. 다른 나라에서 태어났다면 평생 갑상선암이 있는 줄도 모르고 편안하게 살았을 사람이 갑상선암 수술을 받고 갑상선 절제로 인해서 갑상선 기능저하증 환자가 되어 약을 평생 먹는 일은 막아야 합니다.



암 생존자들이 늘고 있다고 하는데, 이들에 대해서 국립암센터가 준비하는 일이 있을까요?

국립암센터가 만들어진 지난 21년 동안, 암의 5년 상대 생존율이 43%에서 약 70%로 비약적으로 증가했습니다. 이렇게 암 치료성적이 좋아지면서 암 생존자가 200만 명을 넘어섰습니다. 암환자에 대해서 생존만 하면 그것으로 충분하다고 생각하는 사람들이 많겠지만 환자들은 수술, 항암치료, 방사선치료로 온 몸이 만신창이가 된 상태입니다. 또한 재발이나 전이에 대한 불안에서 오는 스트레스, 직장이나 사회로의 복귀의 어려움 등 많은 문제점을 지닌 채 살아가게 됩니다.

암 생존자가 겪는 다양한 어려움을 타개하기 위해 정부는 2017년부터 ‘암생존자통합지지사업’을 추진 중이

며, 국립암센터가 그 중심적 역할을 하는 ‘중앙암생존자 통합지지센터’로 지정받아 활동하고 있습니다.

국립암센터는 암 생존자들이 신체적, 정신적 건강을 되찾을 수 있도록 도와주는 것은 물론 일상복귀에 성공할 수 있도록 국가 차원의 통합지지서비스를 제공하기 위해 노력 중입니다. 앞으로도 정책적 지원뿐만 아니라 암 생존자에 대한 범사회적 관심과 공감대가 형성되도록 노력해 나가겠습니다.

국내 암 치료와 연구에서 앞으로 우리나라가 더욱 집중해서 투자해야 할 분야가 있다면?

우리나라 암 치료 성적은 세계 최고수준을 달성하고 있습니다. 그 놀라운 성적은 암 예방, 조기검진, 적절한 치료가 유기적으로 작동되어 이루어진 것이지만, 암 치료의 내용을 살펴보면 다른 선진국에서 개발한 암 치료제와 의료기술로 달성한 것입니다.

우리나라도 이제 10대 경제강국에 도달한 만큼 항암신약과 신기술을 자체 실력으로 개발해야 합니다. 그러나 이런 신약개발은 단기간에 달성할 수는 없고, 적어도 10년 이상 꾸준히 투자해야 합니다. 그러나 단기간에 성과가 안 난다고 투자를 하지 않는다면, 십년 뒤에도 똑같은 말을 할 것입니다. 오늘 투자를 시작해야 십년 뒤 성과를 거둘 수 있는 것이지요.

다행히 우리나라는 건강보험공단에서 전 국민을 하나의 보험으로 묶고 있고, 공단에서 검진사업도 하고 있습니다. 따라서 검진할 때 전 국민의 생활습관과 검진결과를 확보해 그 중에서 누가 암에 걸렸는지, 어떤 치료를 받았는지, 생존율은 어떻게 달라지는지를 알 수 있습니다. 더욱이 그 사람의 유전자 정보도 각 병원에서 검사를 통해 확보되어 있습니다. 이 모든 자료를 연결하기만 한다면 전 세계에서 가장 질이 높은 빅데이터가 될 것입니다.

2021년 9월 국립암센터는 국가암빅데이터센터로 지정되어 이 모든 자료를 연결하는 법적 근거를 가지게 되었습니다. 이 빅데이터를 국립암센터가 구축하지만, 이것을 국내 연구자들에게 개방하여 연구를 활성화한다면, 국내 기반의 신약과 신기술로 이어질 것이 자명합니다.

- 암 예방에서 가장 중요한 것은 금연 등 건전한 생활습관
- 알코올은 1군 발암물질, 술 권하는 ‘건배문화 없애기’ 캠페인
- 암의 5년 상대 생존율 43%에서 약 70%로 비약적 증가
- 200만 명 돌파 암 생존자, 일상복귀 통합지지서비스 제공 노력
- 편의점 담배광고를 금연광고로 대체, 정부가 광고비 지불 제안

‘코로나보다 더 무서운 담배, 금연하세요!’를 캐치프레이즈로 금연홍보캠페인을 전개하신 바 있습니다. 금연운동을 전개하시면서 기억에 남는 일이나 보람을 느꼈던 순간이 있다면?

제가 한국금연운동협의회 회장을 맡고 있던 2015년 1월부터 담뱃값이 2천 원 인상되었고, 2015년 5월에 국회에서 담뱃갑 경고그림 도입이 결정되었습니다. 당시 담배회사의 반대가 심해서 통과가 쉽지 않았는데, 금연운동가들과 언론이 하나가 되어 성공한 것입니다.

한편 아쉬운 점은 2014년에 정부가 ‘범정부금연종합대책’으로 담배판매 소매점에 광고를 금지하겠다고 발표했었는데, 지금까지 아무 것도 하지 않고 있는 것입니다. 전 세계 88개국에서 이미 담배광고를 금지하는데 경제 규모 10위 선진국인 우리나라가 이렇게 후진적인 금연 정책을 유지하는 것은 부끄러운 일입니다.

만약 편의점에서 담배회사로부터 받는 광고비 수익을 포기하기 어려운 측면이 있다면, 담배광고가 있는 자리에 정부가 금연광고를 하면서 편의점에 광고비를 지불한다면 문제를 해결할 수 있지 않을까 싶습니다.

의사이면서 또한 등단 시인으로 왕성한 활동을 이어가고 계십니다. 시인이자 작가로서 천착하고 있는 삶이나 작품의 주제는 무엇인가요?

서울대 의대에 다닐 때 신경림 시인을 만나《창작과비평》을 통해 정식으로 등단하게 되었습니다. 제게 있어서 시를 쓴다는 것은 살면서 인생을 성찰하는 과정이고, 시는 특별한 깨달음의 결정체라는 생각을 하곤 합니다. 매

일의 일상을 일기처럼 적다보면, 어느 특별한 날의 특별한 순간들이 시(詩)로 표현됩니다.

1년 반 전에 네 번째 시집《우산이 없어도 좋았다》를 10년 만에 출간했습니다. 짧은 날 뜻하지 않게 시인으로 등단했을 때는 의사와 시인이 정반대의 길처럼 느껴져 갈등을 느꼈지만, 지금은 좋은 의사가 되는 과정과 좋은 시를 쓰는 일이 다르지 않다고 여겨집니다. 시를 써오면서 느끼는 것은 생명과 인간에 대한 사랑이 가장 고귀하고 오래 남을 것이라는 생각을 합니다.

끝으로 원장님의 건강유지 비결, 그리고 <더 행복한 건강생활> 독자들에게 들려주고 싶은 삶의 철학이 궁금합니다.

건강을 지키는 비결은 우선 나쁜 것을 하지 않는 게 중요하다고 생각합니다. 즉 술, 담배, 과식, 과로, 스트레스를 피하는 것이 중요하지요. 다음으로 운동이 중요한데, 저는 골프도 치지 않고, 할 줄 아는 운동은 오로지 산책과 등산뿐입니다. 일이 바빠도 점심식사 후 매일 국립암센터 뒷산인 정발산을 40분 정도 빠르게 산책하는 게 저의 건강 비결입니다.

또한 정신건강도 매우 중요하다고 생각되는데, 인생에 끌려가지 않고, 어떤 일을 하든 즐기면서 살고자 노력합니다. 금연 운동을 할 때도 힘든 일이 많았지만 즐기면서 했기에 지지치 않고, 포기하지 않을 수 있었습니다.

지금까지 살면서 크게 상처받지 않고 살아온 것은 운이 좋았던 덕분이라고 생각하고, 감사하면서 살고 있습니다. 누구나, 어느 자리에서나 자기가 할 수 있는 일을 즐기면서 살아갈 수 있다면 좋겠습니다.

4차 산업혁명 시대의 선봉장, 의료기기

글 전상일(한국환경건강연구소 소장/유튜브 PHiE tv 운영자)



“좋은 의사란?”
답이 뻔한 질문처럼 여겨진다. ‘살고 싶으면 가장 바쁜 의사에게 찾아가라’는 속설도 있듯, 바쁜 의사가 좋은 의사일 수도 있다. 좋은 의사의 덕목엔 ‘Good Communication’도 빠지지 않는다. 좋은 의사의 요건은 시대와 사회 상황에 따라 변하기 마련인데, 환자의 병을 잘 고치는 의사가 좋은 의 사임은 동서고금을 막론하고 불변의 진리이다.
그런데 의료서비스 분야에 첨단 과학기술과 인공지능(AI) 기술이 속속 도입되면서 좋은 의사의 필수요건인 ‘병을 잘 고치는 방법’이 획기적으로 변할 조짐이 나타나고 있다. 첨단 과학기술이 집 약된 의료기기를 얼마나 잘 활용하느냐에 따라 치료의 결과가 크게 달라질 수 있기 때문이다.

주목받고 있는 ‘디지털 치료제’

환자를 치료할 때 의사 개인의 경험과 지식은 무엇보다 중요하다. 여기에는 이론의 여지가 없다. 하지만 ‘근거중심의학(EBM, evidence-based medicine)’이 힘을 얻으면서 치료 방법을 선택할 때 임 상연구 및 검사결과 등에 대한 의존도가 점점 높아지고 있다. 이러한 상황에서 의료기기는 질병을 진단하고 치료 방법을 결정하는 데 결정적 근거를 제시하는 주체가 되고 있다.
또한 인구의 고령화로 만성질환 유병률이 높아져 사회적 질병부담이 증가하고, 독거노인의 증 가로 의료접근성 문제가 제기되고 있는데, 이를 줄일 수 있는 방안의 하나로 디지털 치료제(DTx, digital therapeutics)의 필요성이 부각되고 있다. 시간과 장소에 구애받지 않고 환자 스스로 비대면 으로 디지털 치료제를 활용하여 질병 치료에 도움을 받을 수 있기 때문이다.

표. 국내 의료기기 관련 대학(원) 현황

대학명	학과명	비고
가천대학교	첨단의료기기학과	학부 과정
가톨릭관동대학교	의료공학과	학부 과정
계명대학교	통계학과(Hustar 의료기기 융합전공)	학부 과정
대구가톨릭대학교	바이오메디대학 의공학과	학부 과정
동명대학교	의료기기학과	학부 과정
성균관대학교	의료기기산업학과	학부 과정
순천향대학교	의공학과	학부 과정
연세대학교	의료기기산업학과, 의공학부(미래캠퍼스)	학부 과정
울지대학교	의료공학과	학부 과정
이화여자대학교	휴먼기계바이오공학부	학부 과정
전남대학교	헬스케어메디컬공학부	학부 과정
전북대학교	바이오메디컬공학부(헬스케어기기공학전공)	학부 과정
중원대학교	SI의료공학과	학부 과정
한국외국어대학교	바이오메디컬공학부	학부 과정
한림성심대학교	의료기기정보과	학부 과정
한양대학교	전기 · 생체공학부(바이오메디컬공학전공)	학부 과정
강릉원주대학교	의료기기융복합학과(일반대학원)	대학원 과정
광운대학교	의료기기산업전공(스마트융합대학원)	대학원 과정
국민대학교	바이오의료기기연구실(기계공학과/의생명융합학과대학원)	대학원 과정
동국대학교	의료기기산업학과(특성화대학원)	대학원 과정
서울대학교	의과대학 의료기기산업학과(일반대학원)	대학원 과정
아주대학교	의과대학 대학원 융합의과학과 의료기기산업전공	대학원 과정



국제 디지털 치료제 협회는 디지털 치료제를 ‘질병을 예방 · 관리 · 치료하기 위해 환자에게 근 거 기반 치료제 개입을 제공하는 소프트웨어 의료기기’로 정의하고 있다. 국내에서도 올해 최초로 국산 디지털 치료제가 나올 것으로 전망된다.

인공지능 기술이 의료기기와 융합되면서 의료기기는 진화를 거듭하고 있다. 이미 일부 질병의 진단능력은 인간보다 우수한 성과를 내고 있는 것으로 밝혀졌다. 수술대에서 의사는 이제 로봇을 사용하여 수술을 한다. 질병의 진단 · 치료의 패러다임이 바뀌고 있는 것이다. 이러한 추세라면 의 료기기가 의료서비스의 주역으로 더 확고하게 자리잡을 것으로 여겨진다.

새로운 부가가치 ‘의료기기 산업’

의료기기는 첨단 과학기술의 집약체로써 막대한 부가가치를 창출할 수 있는 매력적인 아이템이 다. 국가적 차원에서 의료기기 산업의 발전에 힘을 써야 하는 이유이기도 하다. 식품의약품안전처 는 ‘식의약 규제혁신 100대 과제’의 일환으로 디지털 헬스케어 기기의 개발을 지원하겠다고 밝힌 바 있다.
한국보건산업진흥원은 의료기기산업 종합정보시스템 사이트(www.khidi.or.kr/device)를 구축하여 의료기기 관련 최신 정보를 소개하고 있다. 우리나라 대학들도 의료기기 산업의 중요성을 인식하고 의료기기 관련 학과를 개설하여 인재 양성에 관심을 기울이고 있다. 의료기기 산업이 우리나라의 4 차산업 혁명시대를 이끌어 갈 선봉장의 역할을 할 것으로 확신하기 때문이다. 의학과 공학, 그리고 융복합 기술에 관심이 있는 학생들에게 밝은 미래가 펼쳐지고 있다. 이제 도전할 일만 남았다.

의학 드라마에서 주인공이 양 손을 정성껏 닦은 후에 오염되지 않도록 높이 들고 수술방으로 들어가는 장면을 자주 보게 된다. 이후 수술 가운이 입혀지고 한 손에 차례로 수술 장갑이 끼워진다. 그리고 날카로운 메스를 잡으면 수술이 시작된다. 수술 장갑은 수술자의 손을 보호할 뿐만 아니라 수술을 받는 환자의 몸도 보호한다. 수술 장갑의 발전은 다른 장갑들과는 달리 그 두 가지를 모두 고려하면서 이루어졌다.

수술 장갑의 탄생

글 오한진(울지대학병원 가정의학과 교수)



얼핏 보면 수술 장갑과 일반 고무장갑은 크게 다르지 않게 느껴진다. 다만 손에 딱 맞게 끼어진다는 점이 다를 뿐인데 그 차이는 무엇인가?

수술 장갑이 손에 딱 맞아야 한다는 점이 매우 중요하다. 수술을 하는 동안 마치 맨손과 같은 정교한 감각으로 운동이 가능해야 하기 때문이다. 수술 장갑의 사이즈는 5~10 사이의 숫자를 0.5단위로 끊어서 말한다. 사이즈가 0.5 늘어날 수록 장갑도 커진다. 수술 장갑은 탄성을 가져야 하기 때문에 고무와 같은 소재의 발명과 발전이 수술 장갑의 역사와 밀접하게 연관되어 있다.

그렇다면 고무가 없을 때는 어떻게 수술 장갑을 만들어서 사용하였나?

고무의 역사는 대략 150년 안팎에 있다. 고무가 없을 때는 장갑 비슷한 것을 대신 사용했다. 1758년 독일에서는 부인과 진찰 시에 양의 맹장을 잘라 손가락에 끼어 사용했는데, 투과성이 있어서 환자와 의사 모두 감염의 위험이 높았다. 그 후 19세기에 이르러 고무로 장갑을 만들게 된다. 그러나 초기 고무장갑은 두껍고 신축성이 없어서 수술하기에 적합하지 않았다. 1844년 굿이어(Goodyear)라는 회사에서 고무에 다른 성분을 첨가하는 기술을 개발하면서 더 가볍고 튼튼하며 잘 늘어나는 장갑을 만들었다. 영국에서는 토마스 포스터(Thomas Forster)가 이를 이용해 수술 장갑을 만들어 냈다.

언제부터 장갑을 끼고 수술하는 것이 일상화되었나?

사실 19세기 중반까지만 해도 의사들은 대부분 맨손으로 여러 사람을 치료하고 수술했다. 1884년 산부인과 의사였던 이그나츠 세멜바이스(Ignaz Semmelweis)는 출산 후에 발생하는 산욕열이 의사들의 손에서 시작된다고 의심해 손을 씻는 규칙을 마련했다. 그 후 산욕열 치사율은 극도로 줄어들어 돌의 인과관계가 증명되었다. 이후 1867년 조셉 리스트어(Joseph Lister)에 의해 석탄산을 사용한 멸균법이 소개되고 사용되었는데, 감염은 예방되었지만 피부에 자극을 주어 피부염이 발생하게 된다. 이것을 해결한 의사가 바로 윌리엄 스튜어트 할스테드(William Stewart Halsted)이다. 그는 존스홉킨스의 초대 외과학 교수로 1894년 굿이어(Goodyear)사와 함께 손의 필수적인 감각을 방해하지 않을 만큼 얇으면서도 강한 소독약에 대한 노출을 줄여 피부염을 예방할 수 있는 멸균된 수술용 고무장갑을 고안하였다. 이 수술 장갑은 효과는 물론이고 피부염 방지에도 효능이 있는 것이 확인되면서 세계적으로 보편화되기 시작했다.



이러한 위험을 막기 위한 대안이 있었나?

1982년 런던의 고무 회사가 녹말이 없는 라텍스 장갑을 개발했다. 장갑 표면에 하이드로겔 중합체 필름을 입힌 것이다. 이는 눈에 사용하는 콘택트렌즈에도 있는 물질로 인체와의 반응성이 매우 낮아 상대적으로 안전한 물질이다. 이 장갑은 ‘파우더-프리’로 불리며 가루 없이 촉촉한 손으로도 장갑을 쉽게 낄 수 있게 되었다. 가루로 인한 육아종 형성을 막을 수는 있지만 비싸다는 것이 단점이다. 1980년대에는 에이즈와 B, C형 간염에 대한 두려움으로 저렴한 녹말가루 라텍스 장갑을 병원과 의원은 물론이고 경찰, 구급대원, 식당, 미화원 등에서도 사용하였다. 사용범위가 넓어지면서 라텍스 장갑에 함유된 단백질과 녹말가루가 결합하여 만들어진 물질이 알러지 반응을 일으켜 접촉성 피부염을 일으키는 사례가 많아졌고, 이 ‘라텍스 알러지’라고 불리는 문제는 아직도 완전히 해결하지 못했다. 그래서 의사만 라텍스 장갑을 제한적으로 사용하고, 그렇지 않은 경우에는 라텍스가 아닌 비닐장갑 등으로 접촉을 차단하는 것이 훨씬 안전하고 경제적인 방법으로 권고되고 있다.

현재는 수술 장갑을 모두 일회용으로 사용한다. 언제부터 일회용 장갑을 쓰게 되었나?

1966년 이후 일회용 장갑을 사용하는 것은 이미 국제적으로 표준화된 상태였다. 그 후 1982년에는 라텍스에 강한 압력을 가해 더 얇고 튼튼한 장갑이 만들어졌다. 하지만 손을 씻고 물기가 있는 손에 장갑을 낀다는 것은 매우 불편하기 때문에 장갑을 쉽게 끼기 위해 장갑 안과 밖에 바르는 파우더가 등장했다. 그러나 파우더를 사용하기 시작한 후 몇 십 년이 지난 뒤, 파우더 가루가 몸에 염증 반응을 일으키고 육아종을 발생시킨 것이 보고되면서 현재 이런 활석 가루는 장갑에 사용할 수 없는 물질로 지정되어 있다. 이후에 대체물로 녹말가루를 사용했으나 이 역시 육아종이 생겨날 수 있다고 보고되었고, 이에 더해 질 검사나 콘돔 사용 등에 의해 녹말가루가 유입되면 골반강과 복강에 까지 육아종이 생겨날 수 있다는 것이 확인되면서 새로운 대안이 필요한 상황이 되었다.



반려견의 가을철 건강관리

글 이후장(경상국립대학교 수의과대학 교수)

뜨거웠던 여름이 지나고 선선한 가을이 왔다. 여전히 한낮 기온은 높지만 아침과 저녁으로는 기온이 크게 떨어져 일교차가 크다. 면역력이 떨어질 수 있기에 사람이나 반려견 모두 건강에 주의가 필요한 시기이다.

일교차가 큰 환절기에는 신체가 기온에 적응하기 위해 과도한 에너지를 소모하게 된다. 이 때문에 면역세포를 활성화시키는 에너지가 급격히 줄어들면서 면역력이 떨어져 각종 질환에 걸릴 수 있다. 사람과 반려견이 환절기에 많이 걸리는 질병은 호흡기 질환이다. 습도가 낮은 환절기에는 사람과 반려견의 기도점막이 쉽게 마르는데, 이때 세균이나 바이러스가 침투할 경우 저항력이 떨어져 감기 등 호흡기 질환에 쉽게 걸리게 된다.

환기가 안 된 건조한 실내에서만 생활할 경우에도 감기에 걸릴 수 있다. 적절한 환기로 깨끗한 공기를 유지하는 것이 사람과 반려견 모두의 건강을 위해서 필요하다. 특히 반려견의 경

우에는 목욕을 시킨 후에 털을 잘 말려주지 않으면 감기에 걸리기 쉬우므로 드라이를 이용해서 털을 잘 말려주어야 한다.

반려견이 감기에 걸리게 되면, 열이 나고 식욕도 떨어지고, 기침과 콧물, 눈곱 등의 증상을 보인다. 그러나 일부 반려견은 감기에 걸렸더라도 기침 증상을 보이지 않을 수 있어서 움직임이 떨어지고, 사료섭취량이 급격히 감소하면, 몸에 열이 있는지 체온을 측정할 필요가 있다. 반려견의 감기는 자연스럽게 회복되는 경우도 많으나 방치할 경우 폐렴이나 기관지염, 중이염으로 발전할 수 있으니 사전에 예방하는 것이 좋다. 집안의 온도를 26~27℃, 습도를 50~60%로 유지해 외부 환경에 대한 변

화를 최소화하는 것이 좋다. 증상이 개선되지 않을 경우에는 신속히 동물병원을 방문해야 한다.

가끔 사람과 반려견 사이에 감기가 서로 전파되는 것은 아닌지 우려하는 사람들이 있는데, 결론부터 말하자면 서로 전파되지 않으므로 걱정하지 않아도 된다. 반려견 감기 바이러스와 사람 감기 바이러스는 종류가 달라서 감염되는 종(숙주)이 정해져 있다. 종과 종을 뛰어 넘어 감염되는 경우는 없다. 다만 반려견들 끼리는 서로 감기가 전파될 수 있어 여러 마리를 키우고 있다면 서로 감기에 걸리지 않도록 주의해야 한다.

반려견과 산책할 때 진드기 노출에 주의해야

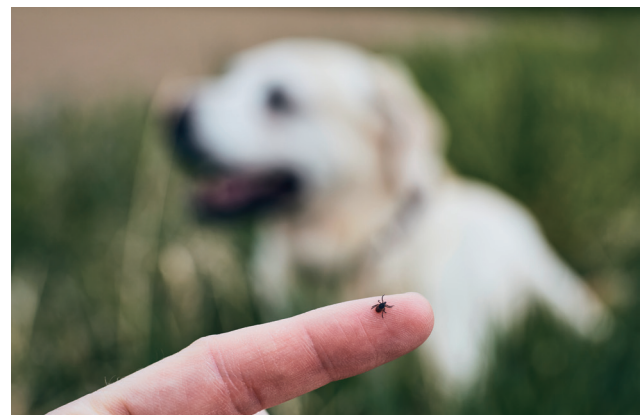
야외활동이 증가하는 요즘 시기에는 야생 진드기를 주의해야 한다. 야생 진드기는 사람에게 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)과 쯔쯔가무시병과 같은 진드기 매개 감염병을 전파한다. SFTS는 참진드기가 매개하는 인수공통전염병으로, 감염될 경우에는 발열, 복통, 구토, 혈소판 감소증 및 백혈구 감소증이 나타난다. 반려견도 SFTS에 감염되는데, SFTS에 감염된 반려견은 고열, 식욕부진, 구토·설사 등의 증상을 보인다.

서울대연구팀이 2019~2020년 동안 국내 동물병원에서 수집한 SFTS 감염 반려견의 증상과 역학적 특성을 국제학술지 Veterinary Research Communications에 보고한 바에 따르면, SFTS 감염이 확인된 반려견 14마리는 말티즈, 푸들, 치와와, 포메라니안, 비숑프리제 등 다양한 품종이 포함되었다.

가장 흔하게 나타나는 증상으로는 발열과 식욕부진(14마리 중 8마리)이었으며, 40도가 넘는 고열(2마리), 활력 저하(6마리), 구토(5마리), 설사(3마리), 혈변(3마리) 등이 관찰되었다. 모든 SFTS 감염 반려견들은 치료 후 정상으로 회복돼 생존하였으며, SFTS 감염 반려견 14마리 모두 도심 속 공원이나 산책로에서 참진드기에 노출되었다고 보고되었다.

다른 진드기 매개 질환인 쯔쯔가무시병은 오리엔티아 쯔쯔가무시균(*Orientia tsutsugamushi*)에 감염된 털진드기 유충에 물려 발생한다. 보통 진드기에 물린 후 1~2주의 잠복기 후 고열, 오한 등의 증상이 나타난다. 반려견은 사람과 달리 쯔쯔가무시병에 감염되지 않지만, 산책을 하면서 반려견의 털에 붙은 진드기가 사람에게 이동하여 병을 일으킬 수 있으므로 주의해야 한다.

따라서 반려견과 산책과 같은 야외활동을 할 경우에는 진드



반려견과 야외활동을 한 후에는 온몸 구석구석을 살펴 야생 진드기가 붙지는 않았는지 확인해주어야 한다.

기 기피제를 활용하여 진드기 노출을 줄일 필요가 있다. 야외 활동 후에는 반려견을 빗질해서 진드기를 제거해 주어야 하며, 특히 발바닥, 귀, 겨드랑이나 사타구니 사이까지 전신을 꼼꼼히 살펴야 한다.

비교적 적은 마릿수의 진드기를 발견하거나 아직 피를 빨아먹기 전인 진드기가 털에 엉켜 있다면, 비닐장갑을 낀 후 전용 핀셋으로 제거하면 된다. 그러나 진드기 제거방법을 정확히 알지 못하거나 이미 피를 많이 빨아들여 통통해진 진드기라면 함부로 제거하기보다 동물병원에 방문하여 제거하는 것이 보호자와 반려견 모두에게 안전하다.

반려견은 겨울철을 대비하기 위해 털갈이를 시작한다. 봄과 가을 환절기 약 2~3주에 걸쳐 털갈이를 진행하는데, 가을에 진행되는 털갈이는 추운 겨울을 대비하여 더 부드럽고 촘촘한 털로 바꾸는 과정이며, 봄철에 진행되는 털갈이는 더운 여름을 대비하는 과정이다. 털갈이가 시작된 반려견을 그대로 방치하면 빠진 털과 그 아래에서 자란 부드러운 새 털이 서로 엉겨 붙어 지저분해질 수 있기에 수시로 빗질해주는 것이 좋다. 빗질은 털만 빗지 말고 털 아래 피부도 적당히 함께 자극해주면, 피부 혈액순환이 활발해져 피부건강과 심신안정에도 도움이 된다.



지난 6월 초, 한국방문 비자를 받기 위해 대사관 앞에 줄을 서 있는 일본 사람들.

‘다른 듯 닮은’ 일본의 코로나19 대응

글 · 사진 배경택(주일본대사관 공사참사관 겸 총영사)

지난 2월, 설레는 마음을 안고 일본 도쿄로 가는 비행기에 올랐다. 일본에서 근무하게 됐다는 얘기를 전할 때마다 많은 분들이 일본은 우리와는 거리상으로는 가깝지만 여러 가지로 상이한 점들이 많아서 ‘가깝고도 먼 나라’라는 말뜻을 실감하게 될 거라고 말씀해 주셨다. 그래서 일본에 있는 동안 어떤 점들이 유사하고, 무엇이 다른지 지켜보고 싶다는 호기심이 일었다. 특히 최근 상당 기간, 질병관리청과 보건복지부에서 코로나19 관련 업무를 담당했던 내게는 더욱 흥미로운 경험이 었다.

일본의 첫 인상은 나리타공항에서 시작되었다. 나리타공항의 첫 느낌은 ‘무척 한산하다’는 것이었다. 당시 일본은 단기체류자격을 가진 외국인의 입국을 전면 제한하고 있었다. 지금은

외국인 입국을 점차 허용하고 있지만, 아직도 외국인 관광객의 입국에는 많은 제한이 있다. 우리나라의 경우, 코로나19 발생 초기에는 공항에서 해외입국자에 대해 자가 진단앱 설치 등을 진행했지만 외국인 입국을 전면 금지하지는 않았기에 입국자보다 입국자 통제 행정 업무를 수행하는 인력이 더 많은 일본 공항의 모습이 무척 낯설게 다가왔다.

지역보건소 및 민간의료기관도 무료 검사

일본에 입국한 직후 7일 간의 자가 격리를 시작했다. 이 기간엔 매일 오전, 오후 두 차례 체온을 측정하여 이메일로 통보해야 한다. 외출은 원칙적으로 금지되지만, 음식을 사기 위해 편의점 방문은 허용되었다. 그리고 해제 전 자비로 PCR검사를 해

야 하는데 한국의 입국자 관리방안과 비슷했으나 PCR검사 비용이 1.5만 엔(한화 약 15만 원)이라 좀 비싸다고 느껴졌다.

이후 순조롭게 업무 적응을 하며 한국과 일본이 비슷한 점도 많지만 외국인의 입국을 금지하는 등 일본의 엄격한 정책을 보면서 양국 간 차이도 많다는 것을 알게 되었다. 특히 일본의 외국인 입국 정책은 우리나라보다 훨씬 보수적이었다. 역시 가깝지만 두 나라의 ‘다름’을 느낄 수 있는 부분이었다.

코로나 발생 이후, 한국과 일본은 3년 간 축적된 자료들을 바탕으로 많은 정책을 변경했다. 일본 역시 내가 일본에서 지내는 지난 6개월 동안 많은 보건의료 정책들을 바꾸었다. 코로나 초기 일본은 우리나라의 ‘3T(Test, 검사), (Trace, 추적), (Treatment, 치료) 전략’과 달리 유증상자만 제한적으로 검사했다. 하지만 일본도 검사역량이 확충되자 우리나라처럼 지역 보건소와 민간 의료기관을 통해 무료로 검사를 진행시키기 시작했다. 비록 검사 건수가 늘어나면서 확진자 수가 증가하기는 했지만, 이런 조치를 통해 감염병 확산을 보다 효율적으로 차단할 수 있게 되었다. 다만 최근에는 일본에서도 코로나19 치명률 등을 감안, 무증상자에 대한 무료 검사는 점차 축소되고 있는 실정이다.

외국인 입국 관련 정책들도 서로 많이 닮아가고 있다. 우리나라는 해외 입국 시 사전 PCR검사 없이 1일차 검사만 시행토록 하고 있는데, 이는 코로나19에 관한 지난 3년간 데이터 분석을 통해 예방접종과 의료대응능력이 확보되는 경우, 코로나19에 대한 통제가 가능하고 치명률도 상당히 낮아졌다고 판단하기 때문이다.

일본의 경우에도 비슷한 판단을 하고 있다. 이에 따라 우선 외국인의 하루 입국자 상한을 5만 명으로 확대하고, 이를 점차 폐지할 것을 검토하고 있다. 또한 단체관광객만 입국을 허용하던 제한도 점차 완화되어 조만간 과거처럼 한일 국민 간 무비자 단기관광이 재개될 수 있을 것으로 기대를 모으고 있다.

성숙한 국민의식이 코로나 대응 효율 높여

우리나라와 일본은 지난 3년여 간 코로나 대응에 대해 다음과 같은 이유로 유사한 정책들을 마련하여 ‘다른 듯 닮은’ 정책들을 시행하게 되었다. 첫째로 한일 국민 모두가 정부의 정책과 설명에 대해 충실히 잘 따라 주고 있는 점이다. 코로나19 검사가 필요하다고, 마스크 착용이 중요하다고 얘기하면 정부의 과학적 설명을 바탕으로 잘 이해하고 협조해 주는 훌륭한 국민들 덕분에 양국의 정책들이 과학적 근거를 바탕으로 유사해지



코로나19 대응이 효과를 보임에 따라 최근 일본은 외국인의 하루 입국자 상한을 5만 명으로 확대했다.

고 있다.

두 번째는 양국 의료진들이 코로나19 치료 및 검사에 헌신적으로 참여해 주고 있는 덕분이다. 새로운 감염병 치료에 나선 의료진들은 양국 모두 지금도 코로나 대응에 핵심적 역할을 수행하고 있다. 마지막으로 양국 전문가들이 충실히 연구하고, 연구한 내용들을 WHO와 WPRO 등 국제기구와 국제적 저널에 공유하여 정보를 바탕으로 한 과학적 대처가 가능해졌다는 점을 들 수 있다. 이런 노력들이 한국과 일본이 코로나 등 검역 조치에서 ‘가깝고도 먼’ 나라에서 ‘가깝고도 비슷한’ 국가로 변화될 수 있었던 원동력이 되었다.

앞으로도 보건 분야부터 일본을 비롯한 외국의 정보를 공유해 나가도록 할 필요가 있다. 그리고 이러한 이야기들을 많은 독자들과 나누어 일본을 비롯한 많은 나라들이 사실은 우리와 그리 멀지않은 이웃들임을 널리 알리고 싶다.



1. 친구의 죽음

지난달 한 사람의 친구가 세상과 작별을 고했습니다. 그이는 심장병을 수년간 앓았고 심장이식을 기다리며 입원 중이었습니다.

장기간의 싸움에도 불구하고 고인은 잘 견뎌냈습니다. 지난 설달그믐, 저는 고인의 가족을 대신해서 문병을 갔었습니다. 아버지의 상태를 걱정한 아들이 요청했습니다. 병원에서 저는 친구와 대화를 나누며 생에 대한 강렬한 의욕이 여전히 그의 생명의 심지를 태우고 있다고 믿었습니다. 마를 대로 마른 그의 몸을 껴안고 저는 당부하고 또 당부했지요. 아직 당신의 소명이 끝나지 않았으니 결코 포기하지 말기를. 그리고 회복되면 함께 할 일에 대해 도란도란 주고받았습니다.

그날 이후 그의 병세는 점차 개선되었습니다. 드디

어 8월에 심장 이식 수술을 하게 되었다는 얘기를 듣고 희망이 부풀어 올랐지요. 그런데 수술이 예약되었던 날, 심장 기증자의 뇌사 판정이 확정되지 않아 기증이 취소되었습니다. 저는 곧 다른 기증자가 나오겠지 하며 안일하게 생각했습니다.

며칠 후 다시 연락이 왔습니다. 친구가 중환자실로 들어갔고, 생명을 부지할 수 있을 지 기약할 수 없다고 했습니다. 저는 황망했습니다. 순식간에 당혹감과 죄책감이 한꺼번에 밀려왔습니다. 아니, 왜 이렇게 되었나? 그날 병원으로 달려갔어야 했는데…. 그리고 사흘 후 친구가 영면했다는 전갈을 받았습니다.

장례식장에서 얼마간 자세한 경과를 들었습니다. 이식이 취소된 다음 날부터, 간에 복수가 차기 시작해서 주사기로 복수를 계속 빼내던 중, 감염이 일어나서 패

혈증이 발병했다는 것입니다. 그러니까 심장병으로 입원해 있을 때부터 이미 간도 심각한 상태에 있었다는 겁니다. 최종 사인은 패혈증이었습니다.

의학적 지식이 부족하기에 정확한 추론인지는 모르겠습니다만 '마음의 요동과 간 질환의 상태가 서로 밀접한 관계에 있었던 건 아닌가? 심장이식에 대한 기대가 지독한 실망감을 가져왔고, 그것이 간신히 통제되고 있던 간의 이상을 초래한 것이 아닐까?' 하는 생각이 듭니다.

2. '반려자'가 있고 없과의 차이

실로 친구는 자신의 생명을 위협하는 병마에 맞서서 의연하게 버텼습니다. 병원에 장기간 입원해 있다 보니 코로나바이러스도 그를 습격했었습니다. 그런데도 그는 희망의 끈을 놓지 않았습니다. 그가 할 일이 아직 남았기 때문이었을 겁니다.

그랬더랬는데, 오래 기다렸던 심장이식이 연기되는 사정에 부닥치자 그만 무너졌던 것입니다. 무슨 소식이 없이 기다리기만 했다면 그냥 버텼겠지요. 그런데 한순간 희망이 찾아왔다가 그것이 꺼져버린 것입니다. 그건 마치 발바닥 밑에서 땅꺼짐을 당한 것과 같았을 겁니다. 도래할 희망의 소실은 절망적 상황을 버티고 있는 몸을 절벽에서 떠미는 것과 같았을 겁니다.

만일 그에게 지극히 신뢰하는 사람이 곁을 지키고 있었다라면 어떠했을까요? 일본의 평론가 에토 준(1932~1999)이 떠오릅니다. 고 김윤식 교수가 그의 마지막 나날에 대해 자세히 적어 놓으신 게 있습니다(《내가 읽고 만난 일본》, 그린비, 2012).

에토 준은 문학이 삶을 구원할 수 있다는 신념을 공공연하게 표명했고 그것을 끝까지 밀고 나간 이였습니다. 그의 아내는 뇌종양을 앓고 있었다고 합니다. 에토 준은 아내를 간호하는 도중에도 일본 근대문학의 아버지라 일컬어지는 '나스메 소세키' 평전을 연재하였습니다.

결국 그의 아내가 세상을 하직합니다. 그는 굴하지 않고 글쓰기를 이어 나갑니다. 그는 그것이 구원이라 생각했을 겁니다. 그런데 그 역시 '폐노증'에 걸립니다.



그대로 두면 패혈증으로 이어질 것입니다. 문학을 구원으로 여긴 그가 한 일이 무엇일까요? 그는 자신의 병과 싸우기 위해 아내의 간병기록을 《처와 나》라는 책으로 만듭니다.

그러나 얼마 후 에토 준은 자살합니다. 그는 마지막 남긴 글에서 '처의 생명이 다하지 않는 한 생명이 다할 그때까지 함께 있다. 결코 처를 혼자 남겨두지 않겠다는 명료한 목표가 있었는데도 처가 죽은 지금은 그런 목표 따위는 아무 데도 있지 않다(앞의 책, 347쪽)'라고 썼다고 합니다. 결국 그의 자살은 처의 부재를 그가 견디지 못했기 때문이었습니다. 글쓰기는 구원이 못 되었습니다. 문학은 사랑의 발끝에도 미치지 못했습니다.

이 책을 읽으며, 저는 제 마음이 새까맣게 정전되는 듯한 섬망 상태에 직면했습니다. 우선은 문학의 하찮음 때문입니다. 하지만 무엇보다도 친구에게 반려자가 없었다는 사실을 상기했기 때문입니다. 그의 아내는 그보다 앞서 암으로 세상을 떠났습니다. 그는 오로지 혼자서 버텼던 것입니다.

그래서 제가 취한 안일한 대응이 너무나 한심하고 부끄러웠습니다. 심장이식이 취소된 날 병원으로 달려갔어야 했는데…. 자책감이 계속 가슴을 망치처럼 때립니다.

존 컨스터블의 <건초마차>

글 김민성 (독립 큐레이터)

존 컨스터블(John Constable, 1776~1837)은 풍경화란 집 밖으로 나가서 직접 자연을 관찰하며 그려야 한다고 믿었던 영국의 대표적인 풍경화 화가다. 성경이나 신화의 주제로 이상화된 풍경을 그린 역사화가 주를 이루고 있던 당시 유럽에선 획기적인 발상이었다. 미술사에서 역사화는 풍경화에 비해 훨씬 높은 가치로 자리매김해왔다. 그러한 풍경화가 컨스터블의 작품들을 통해 숭고한 위엄을 가진 장르로 거듭나게 된 것이다.

컨스터블은 수려한 풍경을 찾기 위해 여러 나라를 여행하는 대신 제분업자였던 부친 소유의 곡창지대 제분소 주변에서 주로 그림을 그렸다. 개천과 우거진 수풀, 그리고 넓은 하늘을 뒤덮는 구름을 가진 고향의 자연이 진정한 존재라고 믿었기 때문이다. 특히 컨스터블은 순간적인 빛의 효과와 자연현상을 연구하고 기록하면서 수많은 모습의 구름을 화폭에 담았는데, 그가 '구름 화가'라고 불리는 이유가 여기에 있다.

작가의 진심 어린 신념은 결국 풍경화의 가치를 세상에 알리게 된다. 그 신호탄이 된 작품이 컨스터블의 <건초 마차(The Hay Wain)>다. 이 작품은 '풍경:한낮(Landscape: Noon)'이라는 원제처럼 평화롭고 목가적인 전원의 경치를 그대로 간직하고 있는 고향의 어느 한낮 풍경을 세밀히 묘사하고 있다.

2m에 가까운 거대한 화면의 아래쪽 중앙에는 개천을 건너가는 수레, 수레를 끄는 농부, 그리고 농부를 마중 나온 개의 모습까지 '건초마차'라는 작품의 주요 주제가 자연스럽게 어우러져 있다. 그 왼편으로는 생동하는 초록빛의 나무와 수풀들이 품어 안은 조용한 시골 농가가 보인다. 그리고 농가 쪽의 하늘에 먹구름을 그려 넣어 한차례 소나기가 지나간 듯 나무 그늘이나 개천에 생생한 물기와 빛을 표현하고 있다.

한편, 작품의 우측에서 보이는 넓은 초원 위로는 밝은 한낮의 빛이 반짝이고, 흰 구름의 저편으로는 파란 하늘이 보인다. 컨스터블의 거의 모든 풍경화에는 낮은 지면에 높고 넓은 하늘이 있다. 지면에는 늘 전형적인 평온한 시골 마을과 자연의 풍경들이 펼쳐져 있고, 하늘에는 대기 중의 빛의 효과를 표현한 무지개나 서로 다른 물기를 머금은 구름의 다양한 모습을 묘사해 놓고 있다.



<건초마차>, 1821, 캔버스에 유채, 130.5×185.5cm, 런던 내셔널갤러리

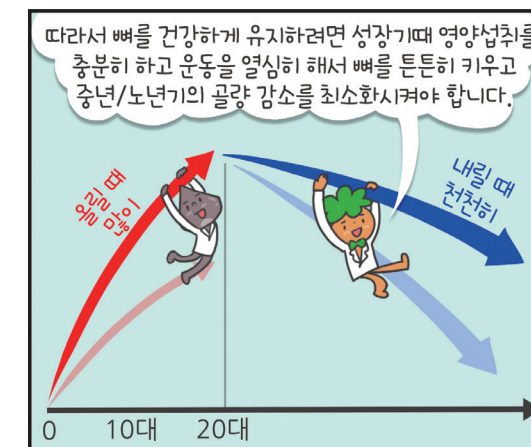
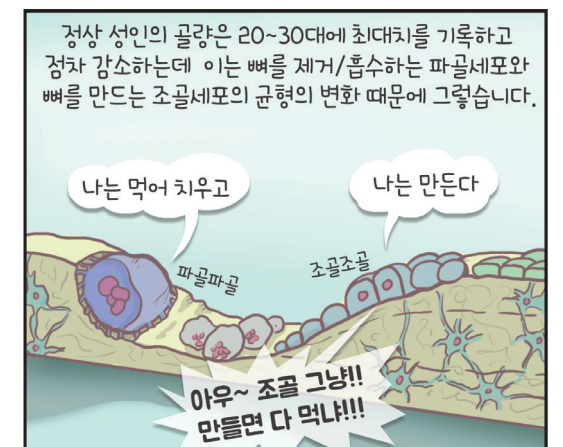
하지만 컨스터블의 풍경화는 긴 시간 어떠한 관심도 끌지 못했다. 그러던 중 1824년 파리 살롱에 <건초 마차>가 출품했을 때, 미술계는 코팅한 듯이 반짝이는 대형 화면과 강렬하고 고유한 자연의 색채가 돋보이는 수작이라며 컨스터블에게 열광했다.

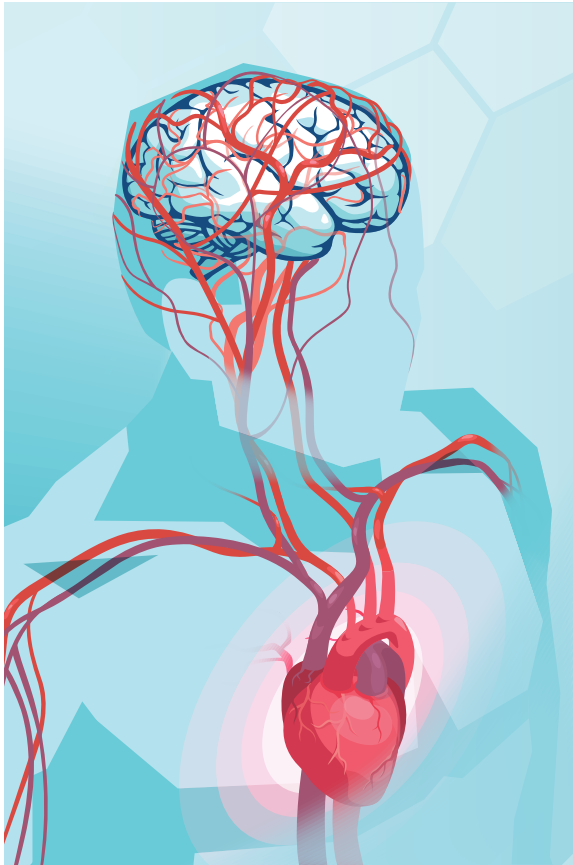
이 작품은 컨스터블을 유명 화가로 널리 알리기도 했지만 온전히 풍경을 주인공으로 하는, 진짜 풍경화의 가치를 보여준 작품이다. 무엇보다 성경이나 신화 주제에 비하여 저평가되고 있던 풍경화를 공식적인 미술 장르의 반열에 올린 점은 서양미술사의 큰 수확이라 할 만하다.

골다공증 예방

골다공증은 뼈의 밀도가 약해지고 구멍이 많이 나서 미약한 충격에도 뼈가 쉽게 부러지는 골격계 질환을 말한다. 건강한 중·노년기를 보내기 위해서는 평소부터 뼈의 주요 성분인 칼슘과 비타민D가 모자라지 않도록 충분히 영양분을 섭취하고 체계적인 건강관리를 해야 한다.

글 · 그림 유진수(삼성서울병원 이식외과 교수)





‘혈관건강의 바로미터’ 혈당, 혈압, 콜레스테롤 수치

압 다음으로 가장 많은 사망의 원인을 차지하는 심뇌혈관질환의 예방과 관리를 위해서는 자신의 혈압, 혈당, 콜레스테롤 수치를 정기적으로 확인하고, 질환을 조기 발견해 규칙적으로 치료받는 것이 중요하다.

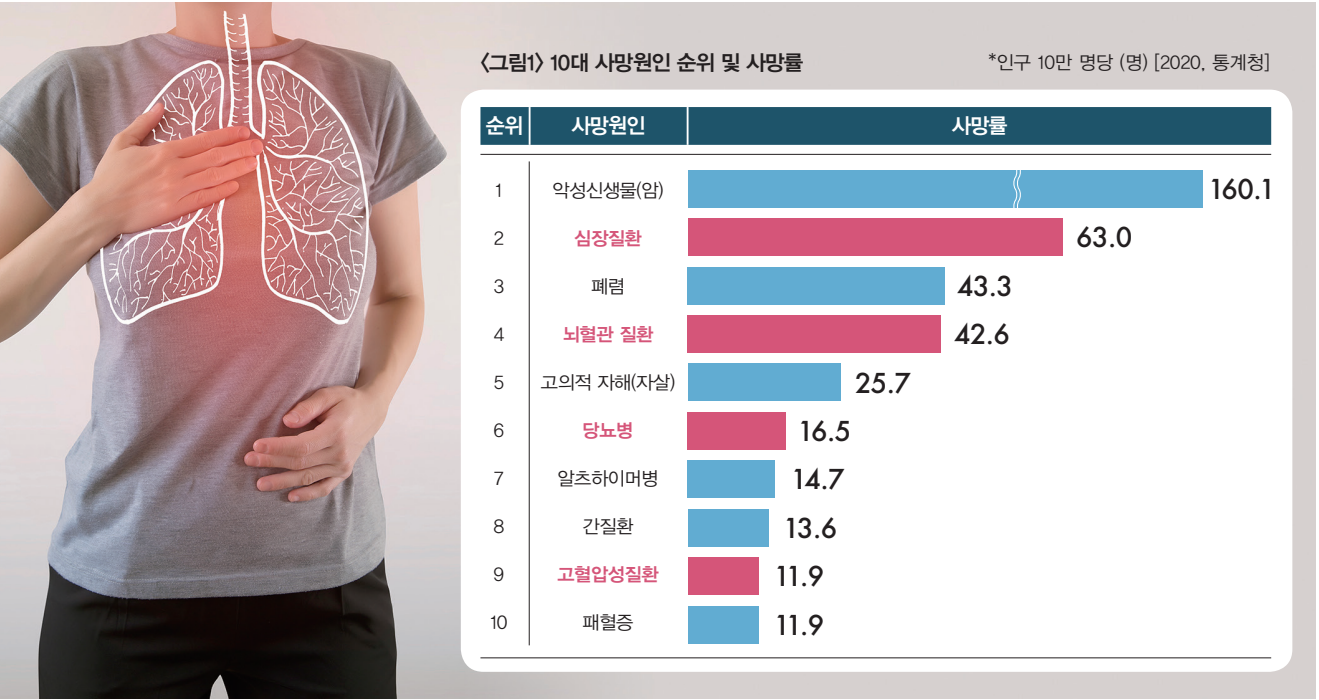
글 대한보건협회

2020년 통계청 사망원인 통계에 따르면 한국인의 3대 사망원인은 암, 심장 질환, 폐렴으로 전체 사망의 44.9%를 차지하는 것으로 조사되었다. 암은 1983년 관련 통계가 만들어진 이래 38년째 부동의 1위로 국민 10명 중 2.7명은 암으로 사망한다.

한국인의 10대 사망원인 중 심장질환(심근경색, 협심증, 심부전 등)과 뇌혈관질환(뇌졸중) 그리고 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 동맥경화증은 혈관 건강과도 직결되어 이들 질환을 총칭해 ‘심뇌혈관질환’이라고 하는데, 우리 국민 5명 중 1명은 심뇌혈관 질환으로 사망한다. (그림1) 질병관리청도 ‘생명의 숫자’, ‘자기혈관 숫자 알기’ 등의 캠페인을 통해 건강한 혈관을 위한 정상 수치를 혈압 120/80mmHg 미만, 공복혈당 100mg/dl 미만, 콜레스테롤 200mg/dl 미만이라고 알리고 있다.

그러나 국민건강영양조사 통계에 나타난 이들 질환에 대한 국민들의 인식률과 질환 관리 상태는 심각한 수준이다. 우리나라 국민의 19세 이상 고혈압 유병률은 22.9%(2020 국민 건강영양조사, 질병관리청)로 전 국민 약 4명 중 1명이 고혈압을 앓고 있다. 그러나 고혈압 환자 10명 중 3명은 자신이 고혈압인지도 모르고(인지율은 69.8%), 5명중 2명은 고혈압인줄 알아도 약을 제대로 먹지 않으며(치료율 65.2%), 치료받는 사람들조차 기준치 이내(140/90)로 혈압을 관리하지 못하는 것으로 나타났다(조절률 69.8%).

당뇨병에 대한 인식과 관리 상태는 더욱 우려스럽다. 당뇨 유병률은 10.7%로 성인 10명 중 1명은 유병자이다. 그러나 인지율 65.1%, 치료율 60.6%, 조절률 25.1%로 10명 중 3~4



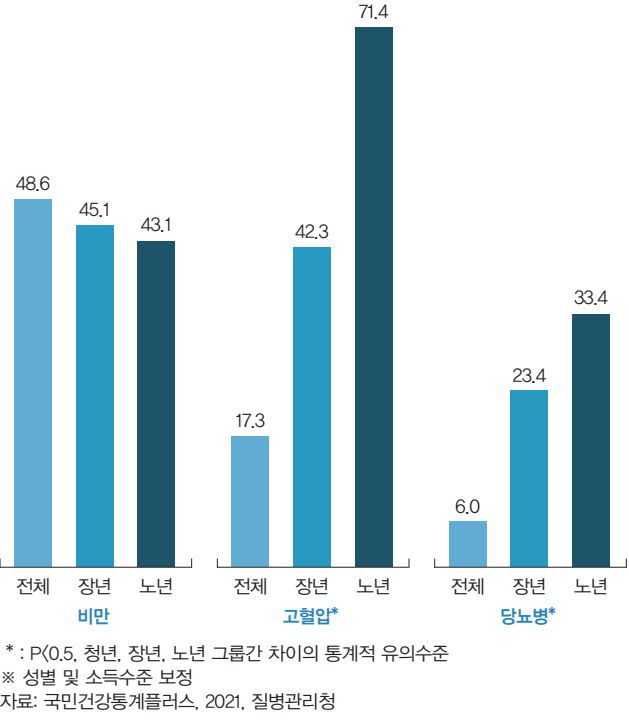
명은 자신이 당뇨가 있는 줄도 모르고, 알더라도 치료받지 않는다. 치료 중에도 혈당을 제대로 관리하는 사람은 4명 중 1명 수준이다.

이상지질혈증의 하나인 고콜레스테롤혈증의 유병률은 21.4%로 성인 5명 중 1명이 유병자다. 이 질환의 인지율은 62.9%, 치료율 55.1%, 조절률은 85.0%로 10명 중 4명은 자신이 고콜레스테롤혈증이 있다는 것을 알지 못하고, 증상을 알더라도 2명 중 1명은 치료받지 않는 것으로 조사되었다.

2019년 통계자료를 보면 고콜레스테롤혈증 유병자(만 19세 이상)의 40% 이상은 비만을 동반하고 있고, 노년층은 다른 연령층에 비해 고혈압(71.4%), 당뇨병(33.4%)을 동반하는 비율이 더 높았다.(그림2) 특히 유병자 중 비만, 당뇨병, 고혈압을 모두 동반한 경우는 청년층은 0.3%, 장년층은 9.2%, 노년층은 14.2%이었다.

심뇌혈관질환 예방 및 관리를 위한 9대 생활수칙으로 질병관리청은 금연, 절주, 스트레스 관리, 싱겁게 먹기, 적정체중 유지, 하루 30분 이상 운동, 자신의 혈당·혈압·콜레스테롤 수치를 알고 관리하기, 뇌졸중과 심근경색 응급증상을 숙지하고 즉시 병원 가기를 권하고 있다. 뇌졸중 초기증상은 한쪽마비, 갑작스런 언어장애나 시야장애, 어지럼증 등이 있고, 심근경색 초기증상은 갑작스러운 가슴통증, 호흡곤란, 통증확산 등이 있다.

〈그림2〉 고콜레스테롤혈증 유병자의 동반질환, 2019. (단위:%)





대한보건협회,
강원도 양구군 보건소와
‘건강증진 활성화 방안’ 토론회

대한보건협회가 오는 10월 20일 강원도 양구군보건소(주혜란 보건소장)와 함께 ‘양구군 청정 자연환경을 이용한 건강증진 활성화 방안 토론회’를 개최할 예정이다. 이번 토론회는 양구군의 청정 자연환경 자원과 산림, 농업, 생태, 문화자원을 치유자원으로 활용할 가능성을 모색해 보고 건강증진 사업과 과학적 데이터 기반의 치유산업 활성화 방안을 논의하기 위해 추진된다.

- 일시: 2022년 10월 20일(목), 오후 2시
- 장소: 강원도 양구군 문화복지센터 공연장
- 내용: 양구군 환경 특성 및 치유자원 현황, 외국과 국내 치유산업 현황 및 효과, 치유자원과 건강증진 활성화 사례
- 기타: 자세한 프로그램은 대한보건협회 홈페이지(www.kpha.or.kr)에서 ‘공지사항’ 참조

사)대한문신사중양회
전남 광주지역 회원 대상
‘보건위생 교육’ 실시

대한보건협회가 지난 8월 24일 사)문신사중양회(임보람 회장) 광주지역 회원 38명을 대상으로 보건위생교육을 실시하였다. 협회는 앞으로도 대한문신사중양회와 함께 전문적이고 체계적인 보건위생교육을 진행할 계획이다.

[회원학회 소식]
한국보건교육건강증진학회,
《근거 기반 보건사업관리의 이론과 실제》 발간

‘국민건강증진종합계획 수립’ 20년을 맞이해 한국보건교육건강증진학회(학회장 김영복)가 건강수명 연장과 건강형평성 제고를 목표로 추진하는 지역사회 기반의 보건사업을 체계적으로 소개하는 《근거 기반 보건사업관리의 이론과 실제》 교재를 발간했다.

이 책자는 국내 보건교육건강증진 전문가 67명이 2년 간 보건사업의 이론, 주요 이슈, 현장 사례를 일목요연하게 정리해 놓은 보건사업관리 지침서로 보건학을 전공하는 학생, 현장 실무자, 연구자들에게 보건사업 전반의 이해를 넓히고, 현장의 사업역량을 강화하기 위한 지침서로 활용될 것으로 기대를 모으고 있다.



⋮

회원 가입 안내

대한보건협회의 국민건강증진 활동을 위해 회원으로 가입해주신 분께
우편으로 매달 《더 행복한 건강생활》을 발송해드립니다.



[회비 안내]

- 일반 정회원 회비 : 입회비 1만 원, 연회비 3만 원
 - 학생회원(학부, 석사, 박사생 포함)회비 입회비 1만 원, 연회비 1만 원
*입회비 협회 처음 가입 시 1회만 납부
 - 평생회원 회비 45세 이하 70만 원, 46세~65세 50만 원, 66세 이상 30만 원
 - 회비납부계좌 신한은행 140-009-956012 (예금주 : 대한보건협회)
 - 특별, 후원회원 별도 안내
- *특별, 후원회원 또는 회원으로 가입을 원하시는 분은 아래 이메일 또는 전화번호로 연락주세요.
이메일 kpha0125@daum.net | 전화 02-921-9520

가을의 의미

글 전병율(대한보건협회 회장)

가을이 되니 ‘천고마비(天高馬肥)’라는 말을 자주 듣게 된다. 가을이 계절 중에서도 가장 좋은 계절이며, 여름철 무더위가 지나고 시원한 바람이 불어오면 ‘아, 이제 정말 가을의 문턱에 들어서구나!’라는 생각이 들기 때문이 아닌가 싶다. 하지만 사실 이 말의 어원이 가을이 되어 하늘이 높아지면 곡물이 풍성해지고 말이 살찌 북방의 흉노족이 쳐들어올 수 있음을 경고하는 의미라는 걸 생각한다면 유비무환(有備無患)의 의미를 더 강조하는 것으로 이해할 수 있다.

가을이 오면 마음이 여유로워지는 것은 인지상정이다. 금년 추석 명절에도 모처럼 가족들과 모여 정담도 나누고 고향에 모인 친인척, 친구들 모두와 맛있는 음식과 정겨운 대화로 즐거움을 나눴다. 중장년층이라면 으레 ‘가을 운동회’와 ‘가을 소풍’의 추억이 떠올랐을 것이다. 필자 역시 운동회 준비를 위해 학년별로 모여서 매스게임 준비도 하고, 학급 대항 달리기 대회 준비를 위해 각 반별로 대표선수 선발전을 하던 기억, 그리고 운동회의 하이라이트인 응원상 수상을 위해 응원 준비에 전력을 다하던 기억이 새롭다. 청군, 백군으로 나뉘 열띤 응원전을 펼치며 ‘337 박수’와 ‘기차박수’로 열기가 달궈진 운동장에선 반별 이어달리기 때 자기 반 선수들을 연호하는 함성으로 절정을 이뤘다.

가을소풍 역시 추억의 시간여행이다. 태어나서 지금까지 서울에서 살고 있는 필자의 경우, 가을 소풍지는 주로 인근의 조선 왕릉이었다. 동구릉·서오릉·서삼릉·현인릉 등에서 친구들과 찍은 사진들을 꺼내 보면 그 당시 유행하던 야외전축을 틀어놓고 고고춤, 다이아몬드 스텝춤도 추고 선생님 몰래 맥주도 훌쩍이면서 대학생 흉내를 내보던 추억이 어제 일처럼 떠오른다. 지금과는 전혀 다른 세상이지만 그때도 가을은 추억과 낭만의 계절이었다.

최근에 다시 천고마비란 말을 떠올리게 된 건 나이 60을 훌쩍 넘은 현 시점에서 말이 아닌 필자의 체중이 하루가 다르게 늘어나는 것을 느꼈기 때문이다. 체중이 늘어난다는 것은 건강관리에 적신호가 켜졌음을 의미한다. 비만의 사전적 정의는 ‘체내에 과다하게 많은 양의 체지방이 쌓인 상태’를 말하며 1996년 세계보건기구에서도 ‘비만은 장기 치료가 필요한 질병’으로 규정한 바 있다.

섭취한 음식량에 비해 활동량이 부족할 때 비만이 생기는 것은 단순한 이치이니 이번 가을에는 평소보다 음식 섭취도 줄이고, 충분한 운동을 통해 날씬한 몸매를 만들어보면 좋겠다. ‘A sound mind in a sound body(건강한 신체에 건강한 정신이 깃든다)’라는 영어 속담이 올 가을엔 더 의미심장하게 들린다.

